Boletín Epidemiológico N° 21 de 2025

Dirección de Vigilancia de la Salud

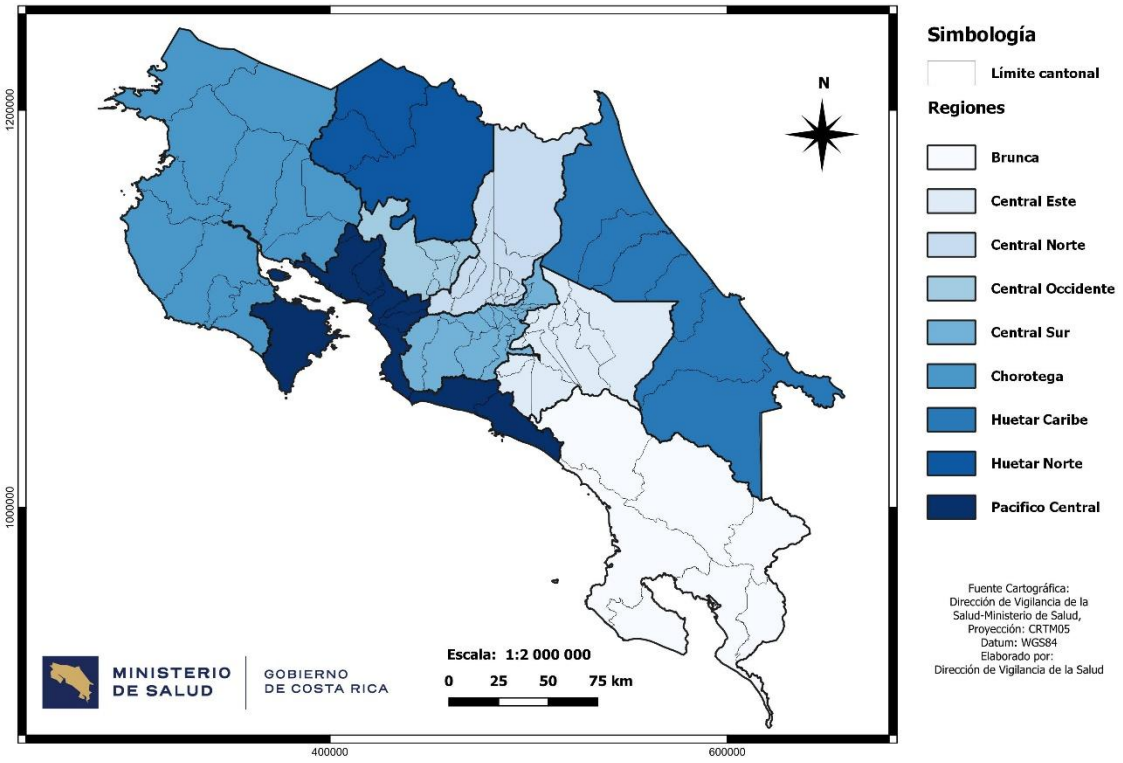
Ministerio de Salud

13 de junio de 2025

Tabla de contenido

Arbovirosis 3
Malaria 8
Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19 16
Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA). 31
Meningitis 33
Tuberculosis 37
Infecciones de transmisión sexual 42
Miasis por gusano barrenador en humanos 55

Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2024



Arbovirosis

Adriana Alfaro Nájera
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de Salud

Adrián Montero Bonilla
Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Dengue

A la semana epidemiológica 22 del año 2025 se notifican **2864 casos** de dengue, de estos 36 acumulados notificados con signos de alarma.

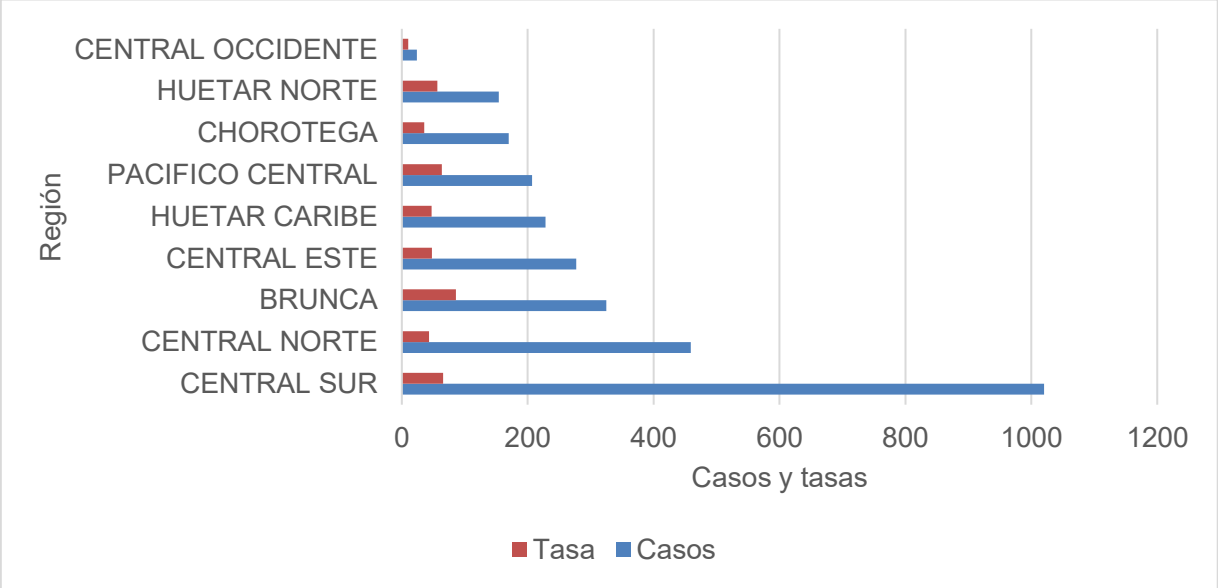
En la región Central Sur se concentra la mayor notificación acumulada con 1020 casos y la tasa más alta en la Brunca 85,8/100.000 habitantes.

Tabla 1.
Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región a la semana epidemiológica 22, 2025 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
Central Sur	1020	65,7
Central Norte	459	43,4
Brunca	325	85,8
Central Este	277	48,0
Huetar Caribe	228	47,2
Pacifico Central	207	63,7
Chorotega	170	35,6
Huetar Norte	154	56,6
Central Occidente	24	10,4
Total	2864	53,5

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 1.
Costa Rica: casos de dengue y tasa por región a la semana epidemiológica 22, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

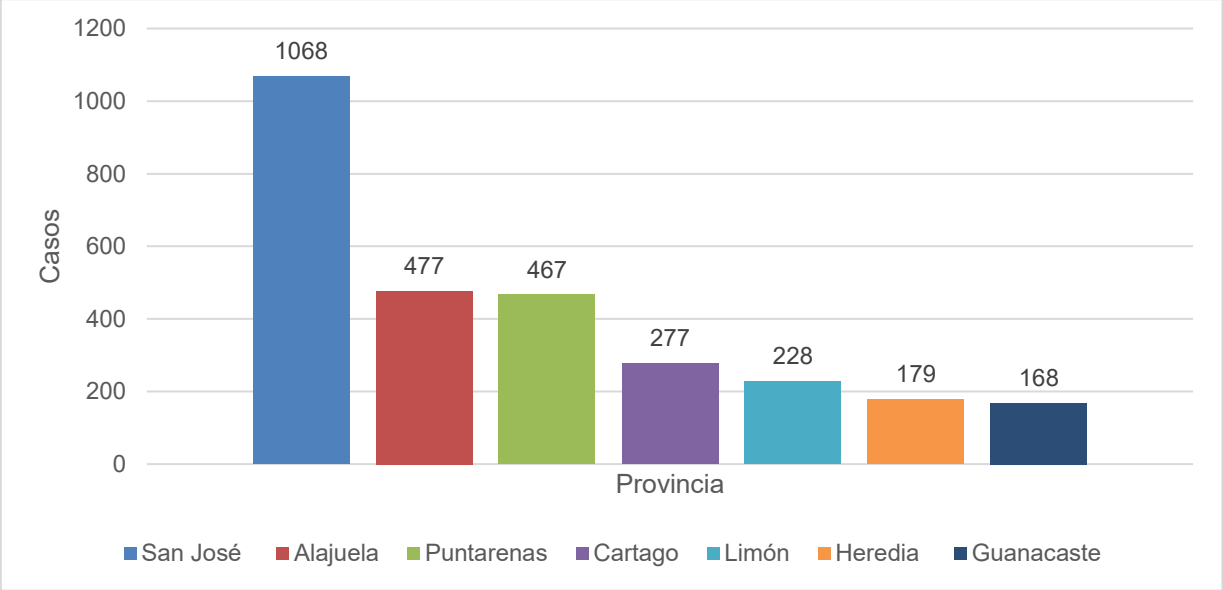
En la tabla 2 se pueden observar los casos notificados por provincia y sexo para el año 2025.

Tabla 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia y sexo, 2025

Provincia	Total casos	Tasa	Femenino	Tasa	Masculino	Tasa
San José	1068	62,2	525	60,8	543	63,7
Alajuela	477	43,7	230	42,6	247	44,7
Puntarenas	467	88,5	188	72,5	279	104,1
Cartago	277	49,8	132	47,6	145	52,0
Limón	228	47,2	98	41,7	130	52,4
Heredia	179	32,0	82	29,4	97	34,6
Guanacaste	168	40,0	76	36,7	92	43,2
Total	**2864**	**53,5**	**1331**	**50,0**	**1533**	**56,9**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia a la semana epidemiológica 22, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Los cantones con mayor número de casos acumulados a la semana epidemiológica 22 son: San José 669 casos, Alajuela 225 casos, San Carlos 123 casos, Turrialba 122 casos y Sarapiquí 109 casos.

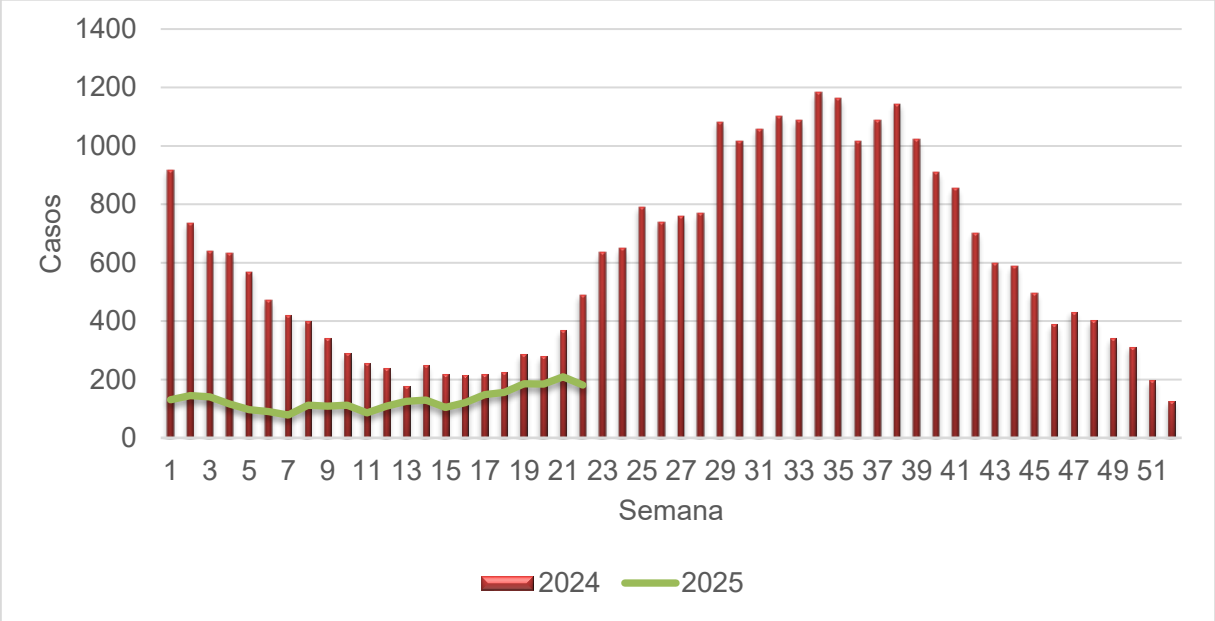
Tabla 3.
Costa Rica: cantones prioritarios en casos de dengue a la semana epidemiológica 22, 2025.

Cantón	Casos	Tasa
101: San José	669	186,9
201: Alajuela	225	67,6
210: San Carlos	123	57,3
305: Turrialba	122	166,6
410: Sarapiquí	109	115,2
605: Osa	95	299,8
601: Puntarenas	92	61,6
702: Pococí	81	50,5

110: Alajuelita	79	78,4
610: Corredores	79	143,6
607: Golfito	69	144,1
103: Desamparados	63	24,7
602: Esparza	55	134,9
705: Matina	50	102,4
109: Santa Ana	48	75,2
119: Pérez Zeledón	48	33,5
303: La Unión	48	40,8
308: El Guarco	40	83,6
704: Talamanca	32	67,8
301: Cartago	31	18,3

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Figura 3.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 22, 2024-2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

A la semana epidemiológica 22 del 2024 se reportó un total de 8625 casos de dengue, para este 2025 se reportan 2864 para un descenso del 67%.

Tabla 4.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 22, 2024-2025.

Semana	2024	2025
1	917	130
2	735	145
3	641	140
4	631	116
5	568	96
6	472	90
7	421	78
8	401	112
9	340	109
10	289	112
11	256	86
12	238	108
13	178	125
14	247	129
15	216	104
16	214	121
17	216	148
18	223	156
19	285	185
20	280	184
21	368	209
22	489	181
Total	**8625**	**2864**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Malaria

Isaac Vargas Roldán
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Sarah Arce Bonilla
Dirección de Vigilancia de la Salud

I. Antecedentes

Costa Rica ha logrado mantener bajos niveles de transmisión de malaria gracias a los esfuerzos continuos y control. Los casos han disminuido notablemente en comparación con el pasado.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) lideran los esfuerzos de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de la malaria, junto con el apoyo del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa). Se utilizan herramientas para el diagnóstico rápido y monitoreo constante de los casos.

Costa Rica forma parte de la **Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y República Dominicana (IREM)** es un esfuerzo conjunto de varios países y organizaciones internacionales con el objetivo de eliminar la malaria en esta región. Esta iniciativa busca coordinar acciones, compartir recursos y conocimientos, y establecer estrategias comunes para combatir y erradicar esta enfermedad.

El objetivo principal para este año es mantener la reducción sostenida de casos de malaria y avanzar hacia la meta de eliminación. Costa Rica se perfila como el próximo país de la región en obtener la certificación de cero casos autóctonos de malaria.

Como parte de las acciones para alcanzar este objetivo, se están llevando a cabo **supervisiones capacitantes** dirigidas a los funcionarios de la CCSS y el MINSA. Estas supervisiones tienen el propósito de actualizarlos en el manejo de la malaria y fortalecer la implementación de estrategias de control, como la estrategia DTIR, en todo el territorio nacional.

Además, se está priorizando el **fortalecimiento de la red de colaboradores voluntarios** en comunidades con barreras de acceso a los servicios de salud y esfuerzos para acerca el diagnóstico y tratamiento a personas en condición de movilidad humana que llevan su paso por el país.

II. Vigilancia epidemiológica

El histórico de transmisión local de malaria presenta los casos registrados en los años 2023, 2024 y 2025, organizados por semana epidemiológica. Se observa una tendencia general a la disminución de casos en el periodo analizado.

Durante el periodo comprendido entre las semanas epidemiológicas 1 a 22, se observa una disminución progresiva en el número de casos de transmisión local de malaria a lo largo de los últimos tres años. En el año 2023, se registraron 327 casos, mientras que en 2024 la cifra se redujo a 144 casos, lo que representa una disminución del **56%**. En lo que va del año 2025, se han reportado 6 casos, lo que equivale a una reducción del **98,2%** en comparación con el mismo periodo de 2023.

Tanto en 2023 como en 2024 se evidenció un patrón de aumento gradual desde la semana 1, alcanzando picos máximos entre las semanas 13 y 15, destacando 52 casos en la semana 14 de 2023 y 7 casos en la semana 16 de 2024. En contraste, en 2025 se muestra una contención significativa de la transmisión local, con casos aislados reportados únicamente en las semanas 2, 3 y 5, sin evidencia de propagación sostenida. Esta disminución progresiva de los casos se asocia con la implementación de intervenciones en salud pública, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la aplicación oportuna de medidas de prevención y control de la malaria en las comunidades afectadas.

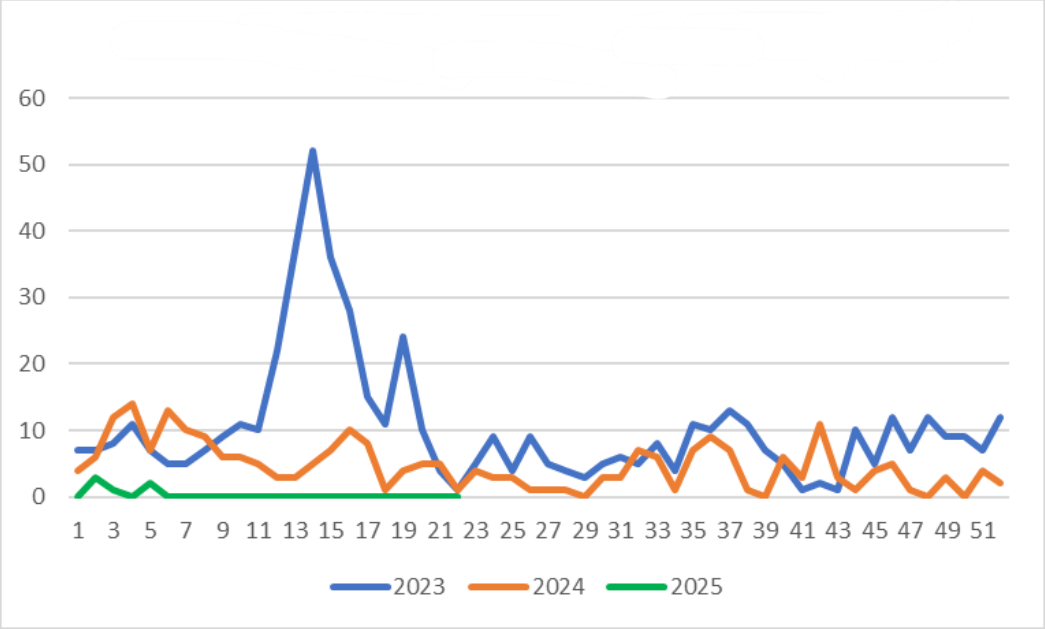
Adicionalmente, en lo que va del año 2025 se ha 1 caso introducido en Santa Rosa de Pocosol y se han detectado 13 casos importados de malaria, siento el 85% *P. vivax* (N=11) y 15% *P.falciparum* (N=2) cuya transmisión ocurrió fuera del país. Estos casos fueron identificados en las localidades de San Pablo (Nandayure), San Ramón (San Ramón), Corredores, Pavas (San José), Cutris (San Carlos) y Los Chiles. Las personas afectadas se desempeñan principalmente como operarios de construcción, peones agrícolas y coligalleros, y además personas que se encuentran en condición de movilidad humana, provenientes de Nicaragua, ruta migratoria desde América del Sur y de retorno desde México y Gabón, África.

Tabla 1.
Costa Rica: Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025 a SE22.

Histórico Transmisión local			
Semana Epidemiológica	2023	2024	2025
1	7	4	0
2	7	6	3
3	8	12	1
4	11	14	0
5	7	7	2
6	5	13	0
7	5	10	0
8	7	9	0
9	9	6	0
10	11	6	0
11	10	5	0
12	22	3	0
13	37	3	0
14	52	5	0
15	36	5	0
16	28	7	0
17	15	8	0
18	11	1	0
19	24	4	0
20	10	5	0
21	4	5	0
22	1	1	0
Total	**327**	**144**	**6**

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Gráfico 1.
Costa Rica: Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025 a SE 22.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Producción de pruebas de diagnóstico

Se ha llevado a cabo un exhaustivo monitoreo a nivel nacional de la malaria, por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud realizando pruebas de diagnóstico mediante búsquedas pasivas y activas de casos.

A semana epidemiológica 22, se registraron 53.112 pruebas de diagnóstico, las cuales responden a las búsquedas realizadas por las instituciones, desglosadas de la siguiente manera, (refiérase a la figura 1):

- **Gotas gruesas de diagnóstico realizadas por CCSS**: 4.844, referirse al gráfico 3.
- **Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por la CCSS**: 23.433, referirse al gráfico 3.
- **Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por la Ministerio de Salud**: 24835, referirse a la tabla 2.
  - **Colaboradores Voluntarios**: 576
  - **Inspectores de Salud**: 23686

Estas cifras reflejan un esfuerzo coordinado y continuo para identificar y controlar la propagación de la malaria en el país. La combinación del método tradicional como lo es la gota gruesa y las pruebas rápidas permite una detección más amplia y oportuna de casos, contribuyendo significativamente a la vigilancia epidemiológica y al manejo efectivo de esta enfermedad.

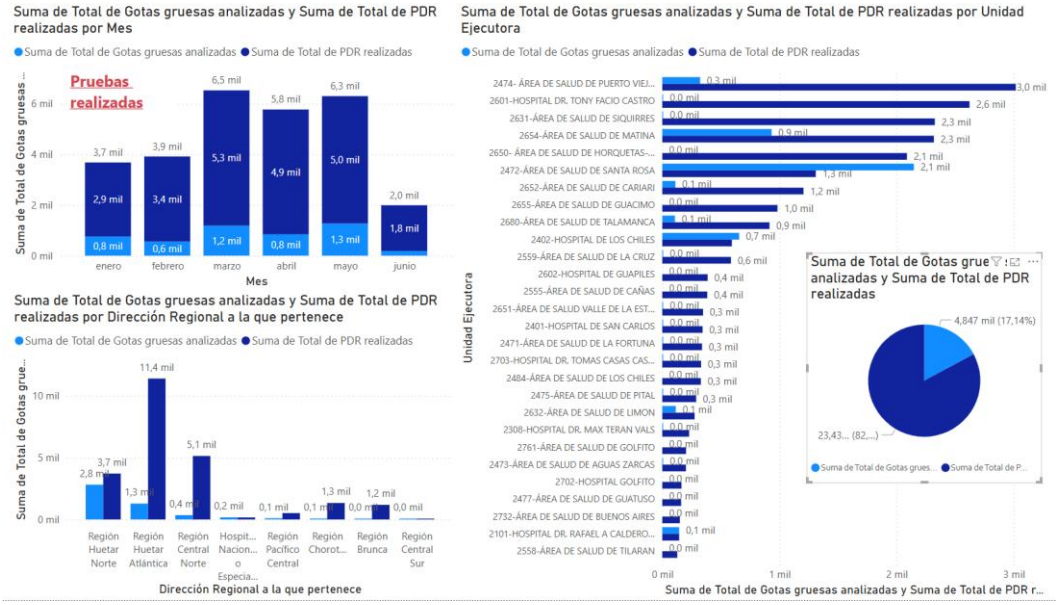
Nota: El registro puede incluir datos duplicados, ya que se toman en cuenta las Gotas Gruesas (GG) para cuantificar la parasitemia antes de iniciar el tratamiento, ante una Prueba de Diagnóstico Rápido (PDR) positiva.

Tabla 2.
Costa Rica: Vigilancia generada por inspectores de salud y voluntarios

Región	Pruebas realizadas por Inspectores de Salud	Pruebas realizadas por voluntarios
Brunca	10.335	51
Central Norte	116	28
Chorotega	2.010	58
Huetar Caribe	4854	196
Huetar Norte	5555	233
Pacífico Central	816	10
Total	23686	576

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Gráfico 3.
Costa Rica: Producción de gotas gruesas y PDRs por parte de CCSS



Fuente: CCSS.

Tabla 2.
Costa Rica: Producción de gotas gruesas y PDRs por parte de CCSS por región

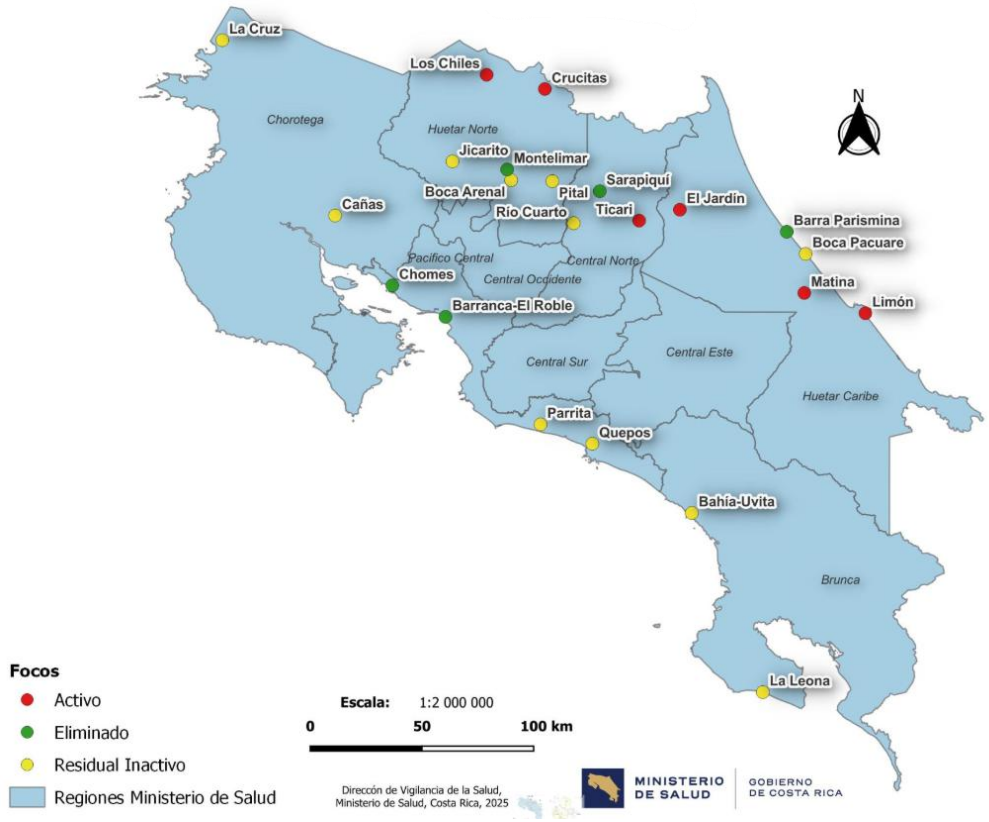
Región	*Suma de Total de PDR realizadas*	*Suma de Total de Gotas gruesas analizadas*
Región Huetar Atlántica	11380	1285
Región Central Norte	5129	351
Región Huetar Norte	3708	2812
Región Chorotega	1332	69
Región Brunca	1182	30
Región Pacífico Central	516	99
Hospitales Nacionales o Especializados	163	170
Región Central Sur	23	28
Total general	**23433**	**4844**

Fuente: CCSS

III. Inventario de focos.

En el país se cuenta con un inventario de focos en constante actualización, actualmente se tienen 6 focos activos, 10 focos residuales inactivos y 5 focos eliminados.

Figura 1.
Costa Rica: Inventario de focos de Malaria a mayo 2025.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

IV. Clasificación del estado histórico y actual de los focos maláricos.

Para que un foco sea declarado como residual inactivo debe transcurrir 1 año sin aparición de casos autóctonos, paralelamente, para que un foco sea declarado como eliminado, debe transcurrir 3 años sin transmisión autóctona del parásito.

Tabla 3.
Costa Rica: Listado de Focos de malaria a Enero 2025, por provincia, cantón y estado actual del foco.

Provincia	Cantón	Nombre del Foco	Estado
Alajuela	San Carlos	Pital	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Boca Arenal	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Monterrey	Eliminado
Alajuela	San Carlos	Crucitas - Llano Verde	Activo
Alajuela	Los Chiles	Los Chiles	Activo
Alajuela	San Carlos	Jicarito	Residual inactivo
Alajuela	Río Cuarto	Rìo Cuarto	Residual inactivo
Guanacaste	La Cruz	La Cruz	Residual inactivo
Guanacaste	Cañas	Cañas	Residual inactivo
Heredia	Sarapiquí	Sarapiquí	Eliminado
Heredia	Sarapiquí	Ticari	Activo
Limón	Matina	Matina	Activo
Limón	Limón	Limón	Activo
Limón	Siquirres	Barra de Parismina	Eliminado
Limón	Pococí	El Jardín	Activo
Limón	Siquirres	Barra Pacuare	Residual inactivo
Puntarenas	Roble	El Roble	Eliminado
Puntarenas	Puntarenas	Chomes	Eliminado
Puntarenas	Quepos	Quepos	Residual inactivo
Puntarenas	Parrita	Parrita	Residual inactivo
Puntarenas	Golfito	La Leona	Residual inactivo
Puntarenas	Osa	Bahia Uvita	Residual inactivo

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19

Roberto Arroba Tijerino
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Mayra Quesada Sanabria
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

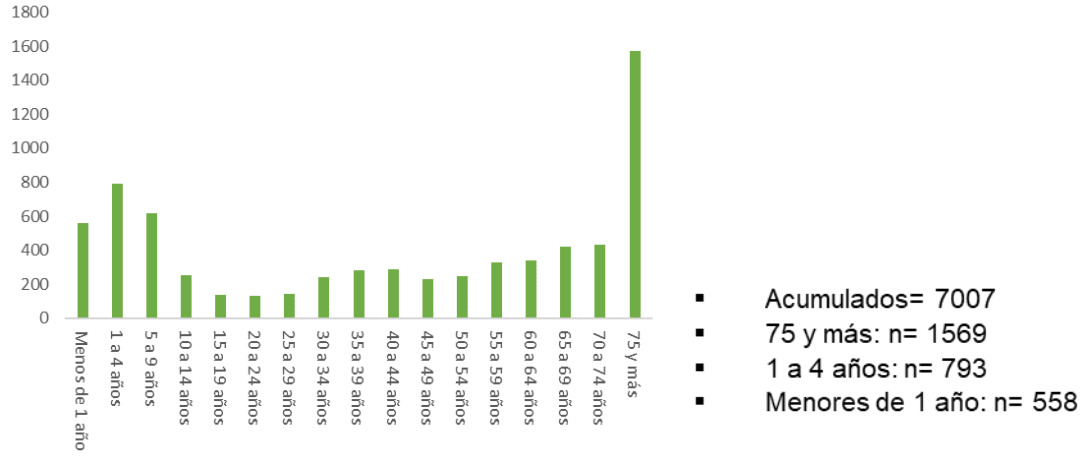
Rafael Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos para la semana epidemiológica 22 de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) y los datos de la semana epidemiológica 21 de las Infecciones Respiratorias Agudas Superiores (IRAS) y la Enfermedad Tipo Influenza (ETI), que según establece el Decreto de Vigilancia de la Salud No. 40556-S del 07 julio del 2017, son eventos de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de las IRAG, por medio de la boleta VE-01, se cuenta con los siguientes datos:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 22 son un total de 7007.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en los niños entre 1 y 4 años y en los mayores de 75 años.

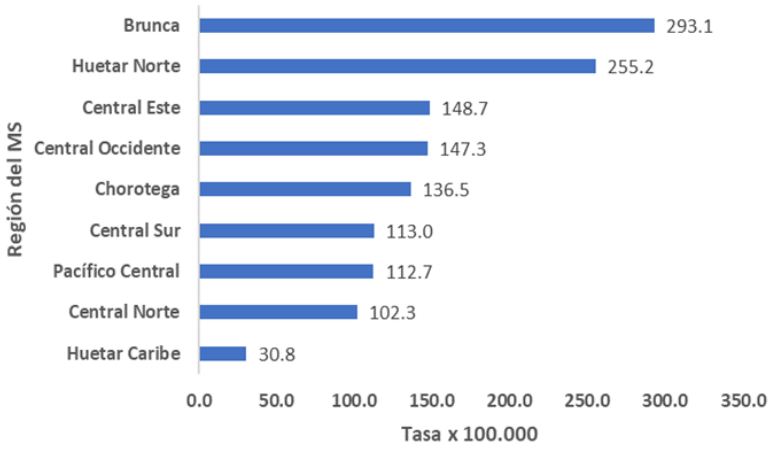
Gráfico 1.
Distribución de casos de IRAG por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 22, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según el gráfico 1, se puede apreciar como en los extremos de la vida (niños entre 1 y 4 años y mayores de 75 años es donde más casos se han presentado).
En el gráfico 2, se observa la tasa de incidencia de IRAG según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 22, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Brunca y la Huetar Norte; las regiones con menor incidencia corresponden a la Chorotega, Central Este, Central Occidente, Central Sur, Central Norte, Pacífico Central y Huetar Caribe.

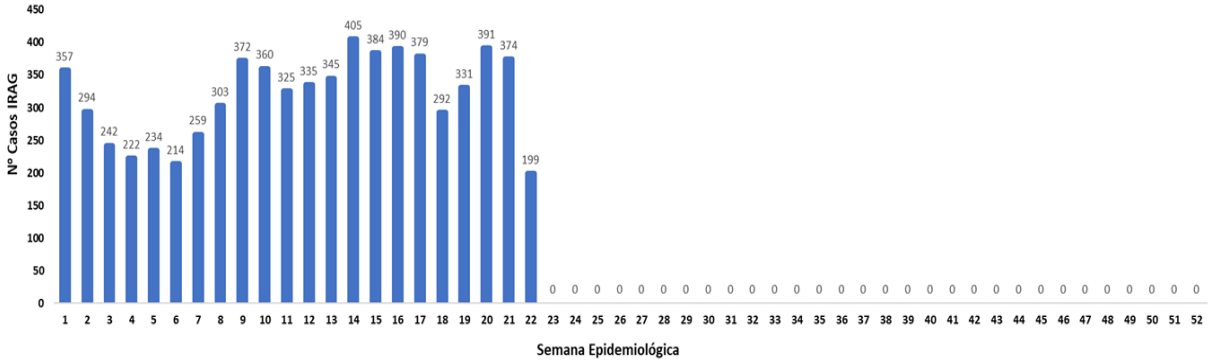
Gráfico 2.
Tasa de IRAG según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 22 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-01 de IRAG, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 3; se puede observar el comportamiento de los casos a la semana epidemiológica 22 del año 2025.

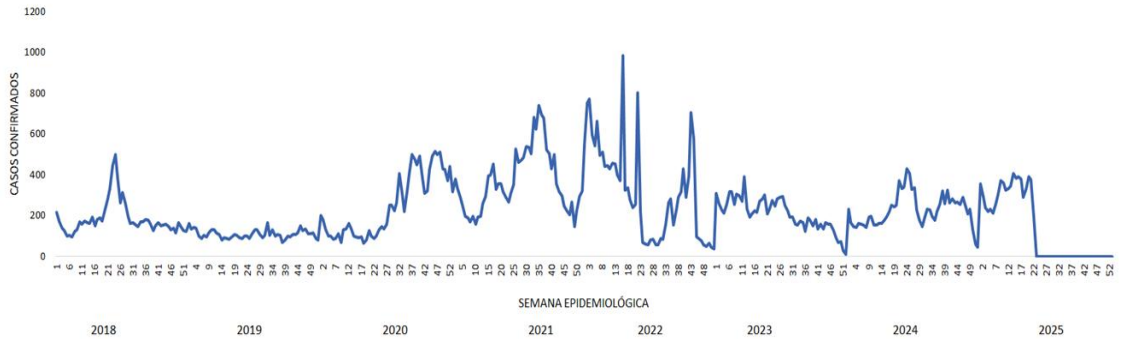
Gráfico 3.
Distribución de casos reportados por boleta VE-01 de IRAG a la semana epidemiológica 22, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAG, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 4.

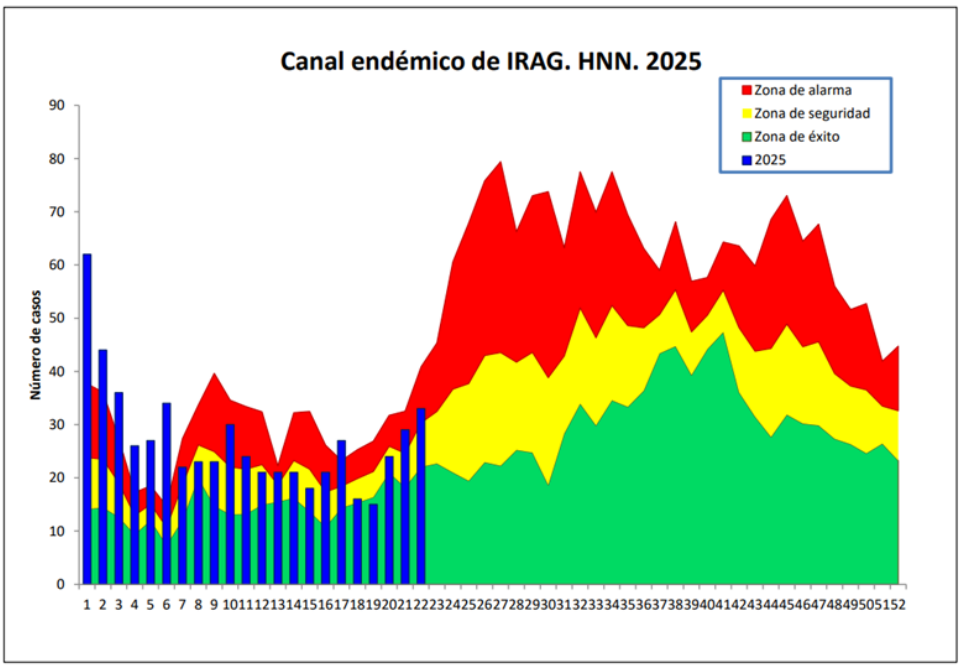
Gráfico 4.
Distribución histórica de casos de IRAG por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

El HNN, para la SE-22 tiene un canal endémico de IRAG que actualmente se encuentra por en zona de alarma, debido a la cantidad de casos que están presentando en este momento, tal como se puede apreciar en el gráfico 5.

Gráfico 5.
Costa Rica: Canal endémico IRAG, HNN, 2025

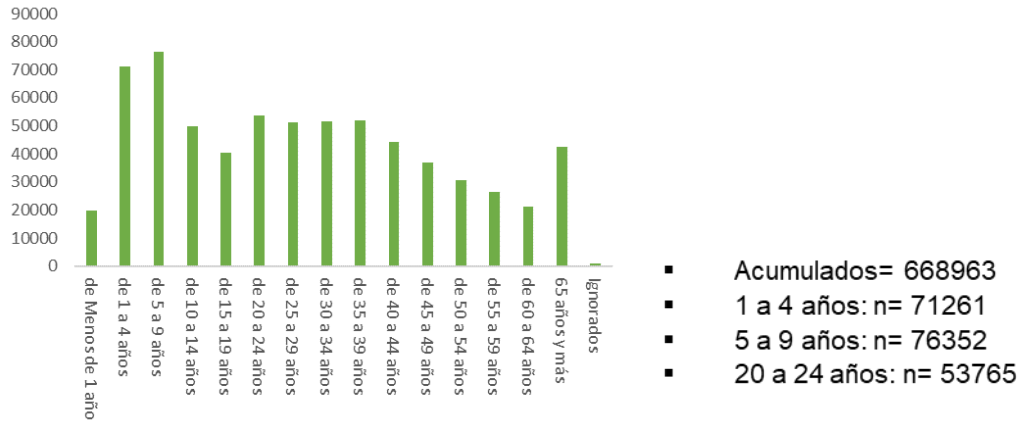


Fuente: EDUS-UVEPCI HNN, 2025.

En cuanto a la notificación de IRAS, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 6:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 22 son 668963.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en menores entre 1 y 4 años y menores entre 5 y 9 años.

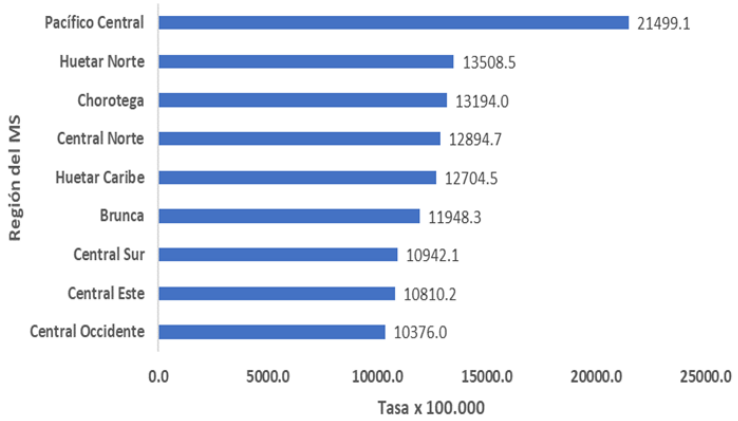
Gráfico 6.
Distribución de casos de IRAS por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 22, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 7, se observa la tasa de incidencia de IRAS según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 22, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Pacífico Central y Chorotega. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Huetar Norte, Central Norte, Huetar Caribe, Brunca, Central Occidente, Central Sur y Central Este.

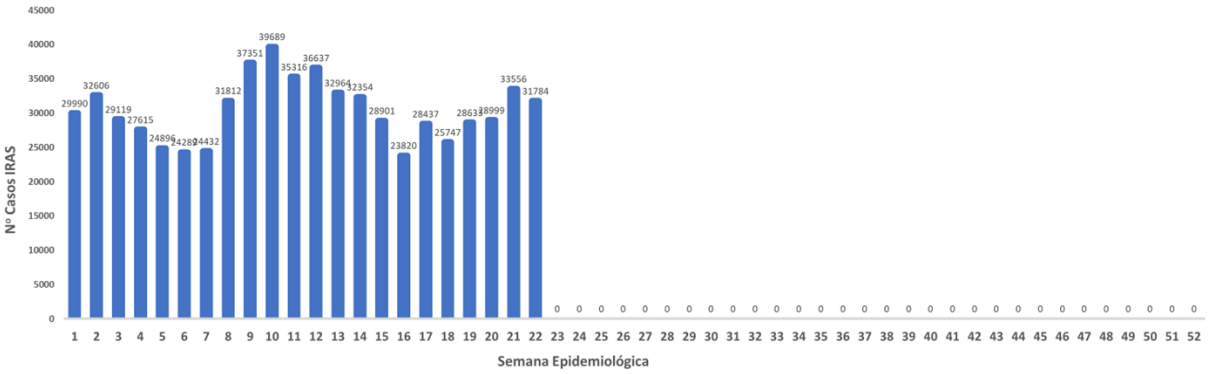
Gráfico 7.
Tasa de IRAS según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 22 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de IRAS, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 8; se puede observar cómo los casos se han comportado a lo largo de estas 22 semanas epidemiológicas del año 2025.

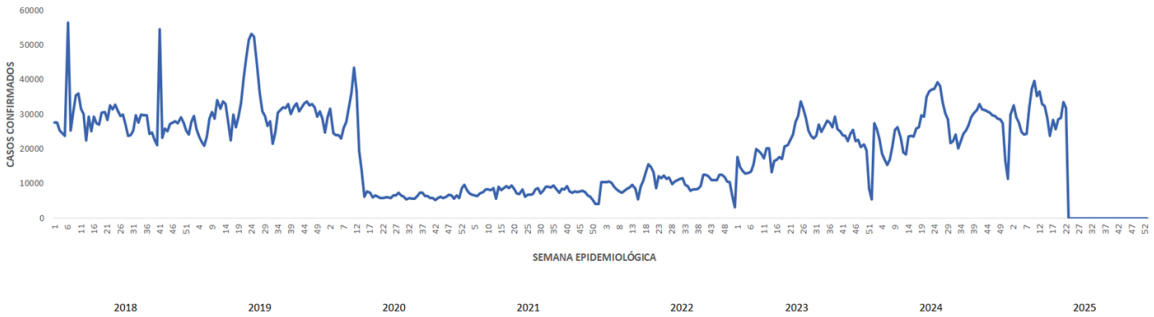
Gráfico 8.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de IRAS a la semana epidemiológica 22, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAS, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 9.

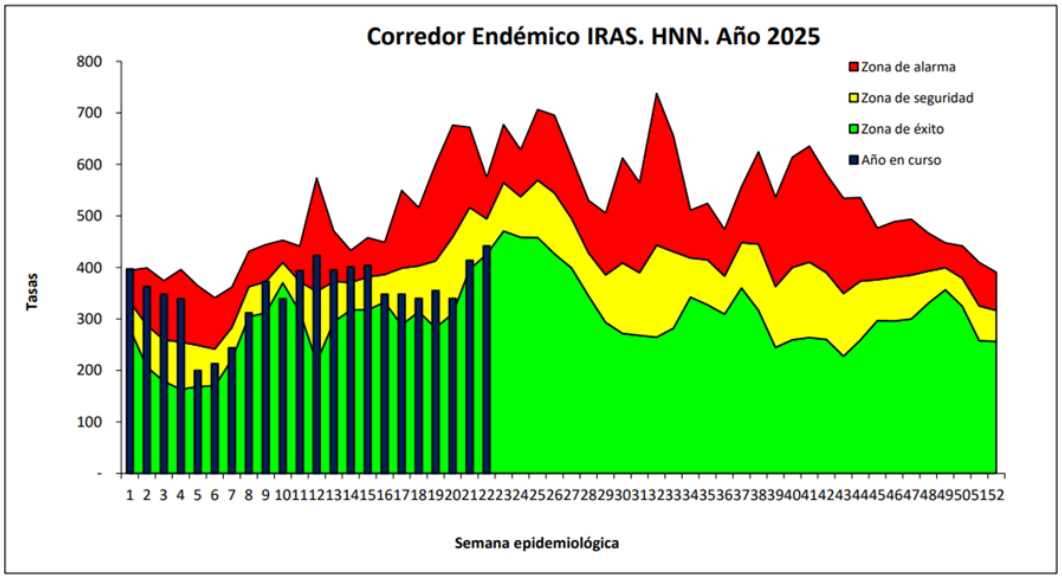
Gráfico 9.
Distribución histórica de casos de IRAS por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 10 se presenta el canal endémico de las IRAS en el Hospital Nacional de Niños, que muestra que a la semana 22 se encuentran en la zona de seguridad actualmente.

Gráfico 10.
Costa Rica: Canal endémico IRAS. HNN. 2025.

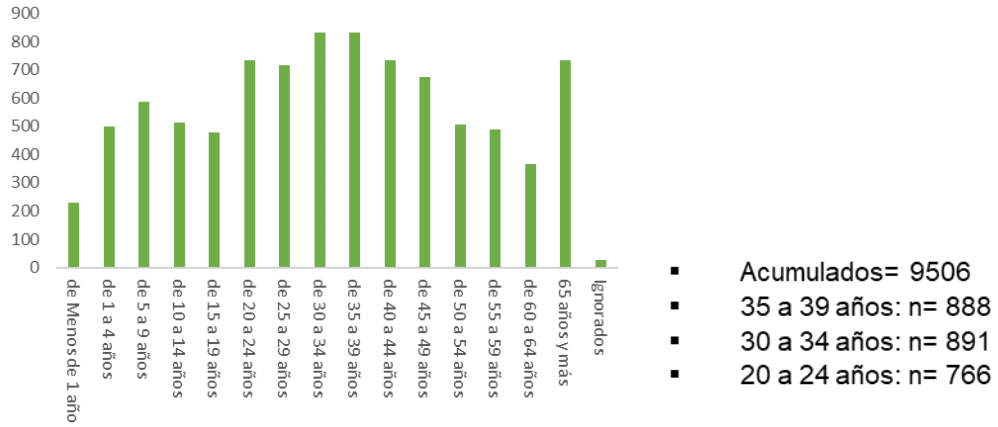


Fuente: Sistemas de Cubos Urgencias-UVEPCI HNN, 2025.

En cuanto a la notificación de ETI, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 11:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 22 son n= 9506.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en personas entre 30 y 34 años y las personas entre 35 y 39 años.

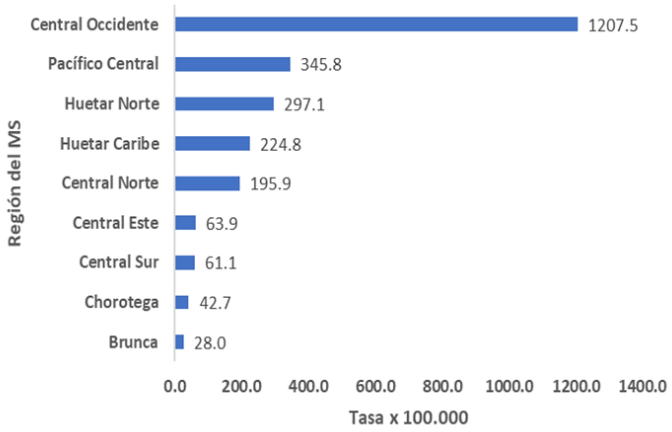
Gráfico 11.
Distribución de casos de ETI por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 22, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 12, se observa la tasa de incidencia por ETI, según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 22, presentando mayor cantidad de casos en la región la Central Occidente. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Brunca, Chorotega, Central Este, Central Sur, Huetar Norte, Pacífico Central, Central Norte y Huetar Caribe.

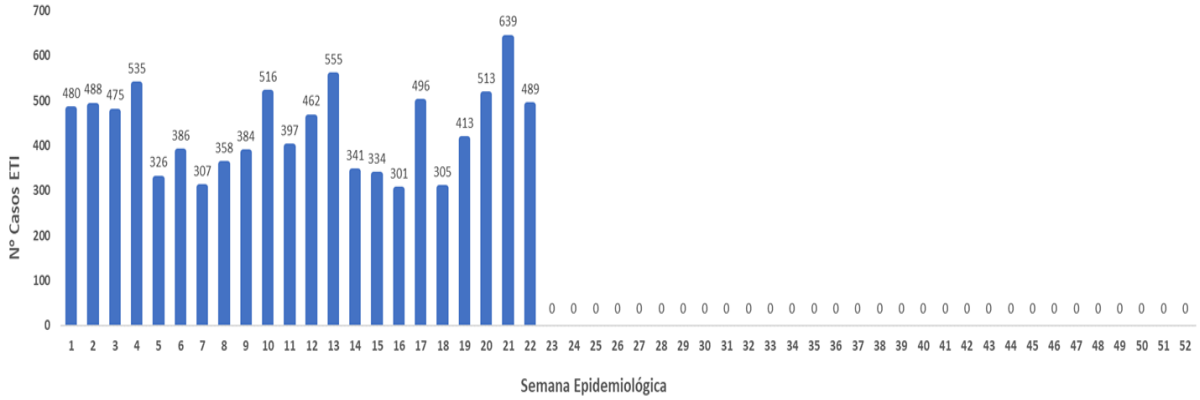
Gráfico 12.
Tasa de ETI por región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 22 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de ETI, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 13; se puede observar cómo se han distribuido los casos en el año 2025.

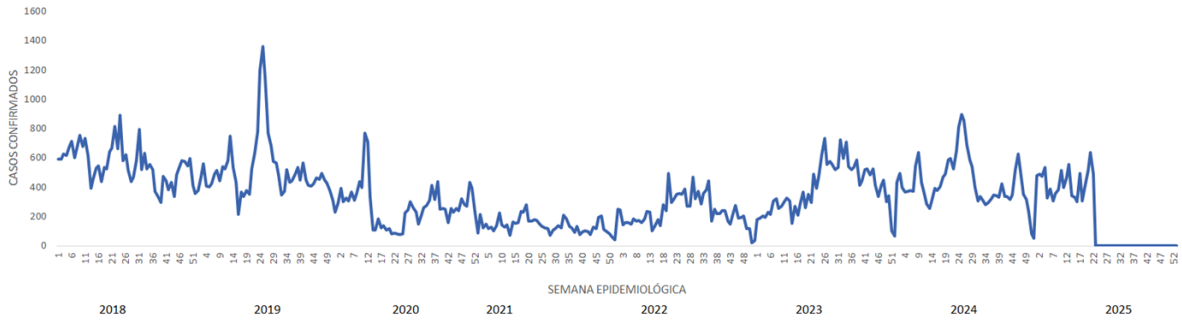
Gráfico 13.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de ETI a la semana epidemiológica 22, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de ETI, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 14.

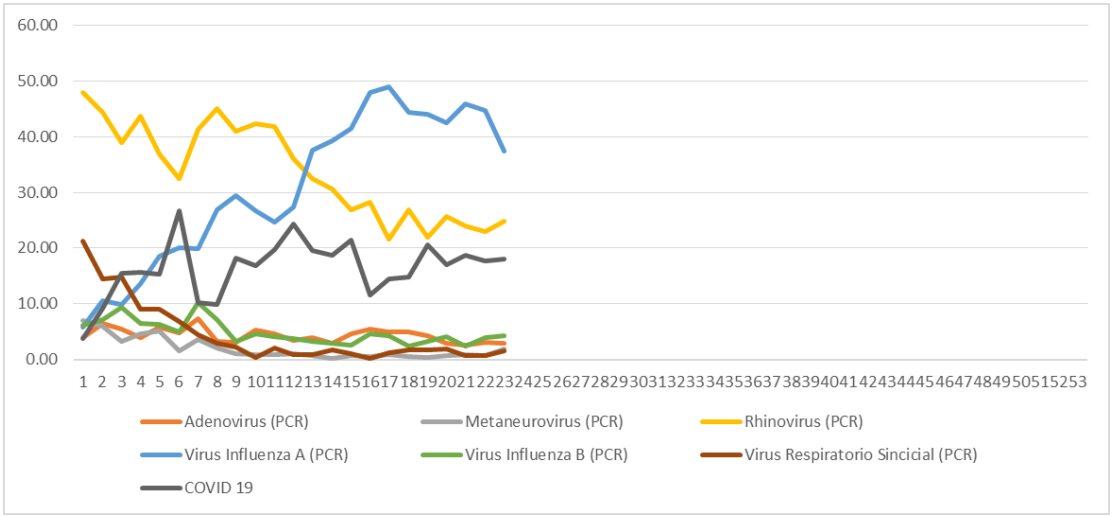
Gráfico 14.
Distribución histórica de casos de ETI por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según se observa en el gráfico 15, se puede ver el comportamiento de los principales virus respiratorios circulantes de la semana 01 a la 23; para la SE-23, en el país el virus de Influenza A es el que más está circulando, seguido del Rinovirus y finalmente, el Covid-19 está en tercer lugar de circulación.

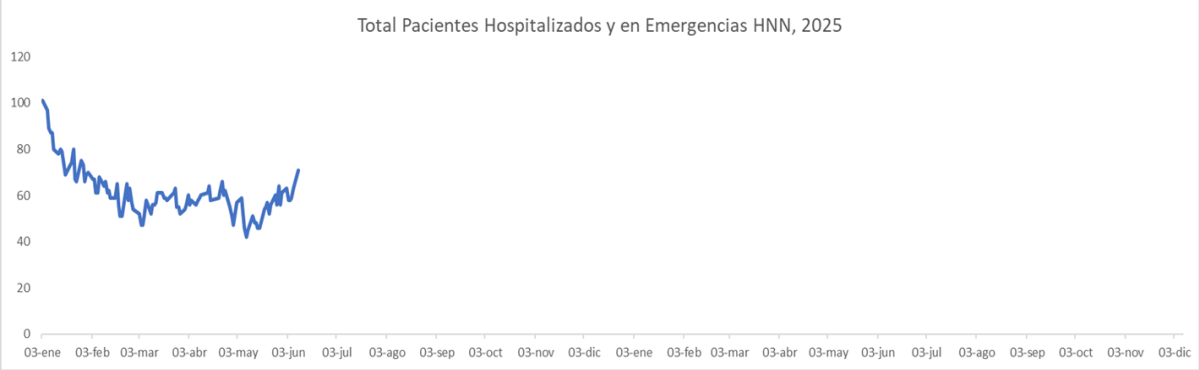
Gráfico 15.
Distribución de virus circulantes de la semana epidemiológica 01 a la 23 en Costa Rica, 2025.



Fuente: Matriz de Resultados de Laboratorio CCSS, Subárea de Vigilancia Epidemiológica 2025.

En relación con los datos específicos del Hospital Nacional de Niños, la situación que se ha presentado a la semana 24 del año 2025 es la siguiente:
Al 9 de junio del año en curso, correspondiente a la semana 24, el total de pacientes respiratorios hospitalizados son 67, lo que corresponde a un porcentaje de ocupación del 100%.

Gráfico 16.
Total de pacientes hospitalizados y en emergencias en la semana 23 del año 2025, Hospital Nacional de Niños.



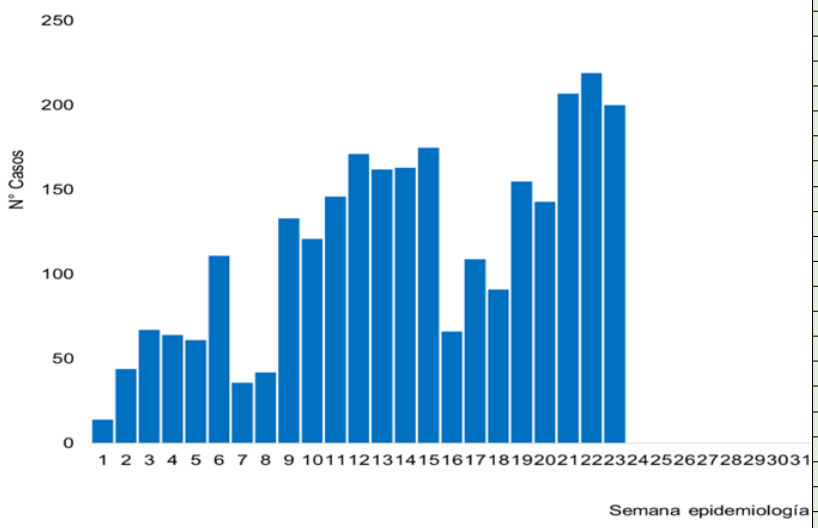
Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2025.

Como observaciones finales se puede indicar lo siguiente:

- IRAG con 7007 casos a la semana 22.
- IRAS con 668963 casos a la semana 22.
- ETI con 9506 casos reportados a la semana 22.
- Actualmente, la ocupación de camas respiratorias en el HNN es de un 100%
- En SE-23, el Virus de Influenza A es el virus que más ha circulado, seguido del Rinovirus y en tercer lugar circula el Covid-19.

Para la enfermedad por COVID-19, durante la semana epidemiológica 23, se reportaron un total de 200 casos confirmados, lo que representa una disminución del 8.67% con respecto a la SE-22 del año 2025 que presentó 219 casos.

Gráfico 17.
Costa Rica: Casos COVID-19, según semana epidemiológica año 2025.

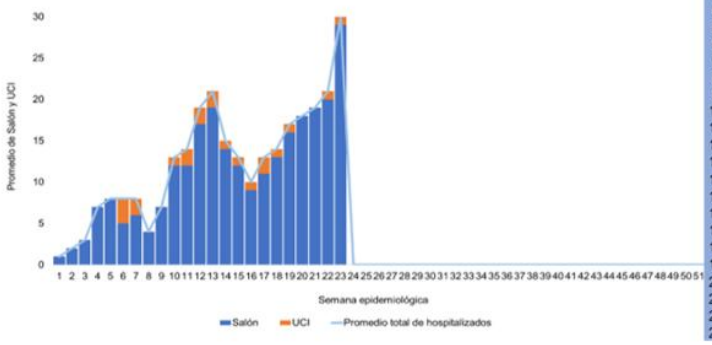


SE	Casos
1	14
2	44
3	67
4	64
5	61
6	111
7	36
8	42
9	133
10	121
11	146
12	171
13	162
14	163
15	175
16	66
17	109
18	91
19	155
20	143
21	207
22	219
23	200

Datos sujetos para actualizar
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, C.C.S.S / Dirección de Vigilancia de Salud, Ministerio de Salud, 2025.

Con respecto a las hospitalizaciones en la semana epidemiológica 23, se reportó un promedio total de 30 hospitalizados, lo que representa un aumento del 42.86% con respecto a la SE-22 del año 2025 donde se registraron 20 hospitalizaciones.

Gráfico 18.
Costa Rica: Promedio total de hospitalizados en salón y Unidad de Cuidados Intensivos, según reporte semanal año 2025.

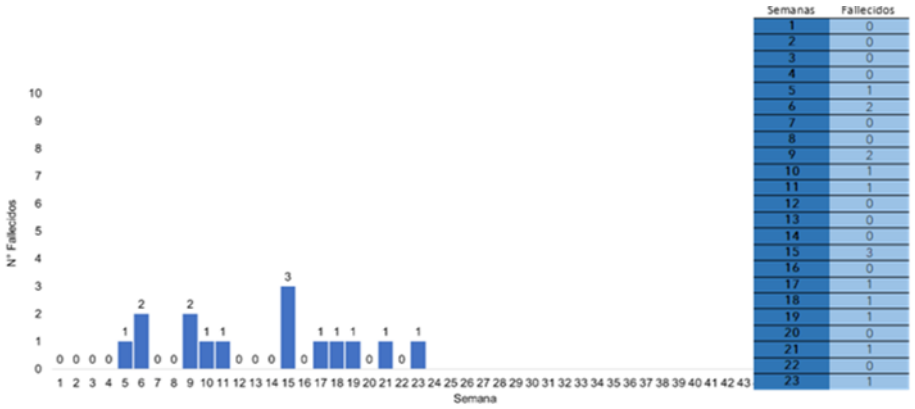


1	1	0	1
2	2	0	2
3	3	0	3
4	7	0	7
5	8	0	8
6	5	3	8
7	6	2	8
8	4	0	4
9	7	0	7
10	12	1	13
11	12	2	14
12	17	2	19
13	19	2	21
14	14	1	15
15	12	1	13
16	9	1	10
17	11	2	13
18	13	1	14
19	16	1	17
20	18	0	18
21	19	0	19
22	20	1	21
23	29	1	30

Fuente: Área de Estadística en Salud, CCSS/Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2025.

En relación con el comportamiento de las personas fallecidas asociadas a COVID-19, durante la semana epidemiológica 23, hubo 1 fallecido; sin embargo, es importante indicar que estos son datos preliminares sujetos a la revisión de los casos.

Gráfico 19.
Costa Rica: Personas fallecidas asociadas a COVID-19, según reporte semanal año 2025.

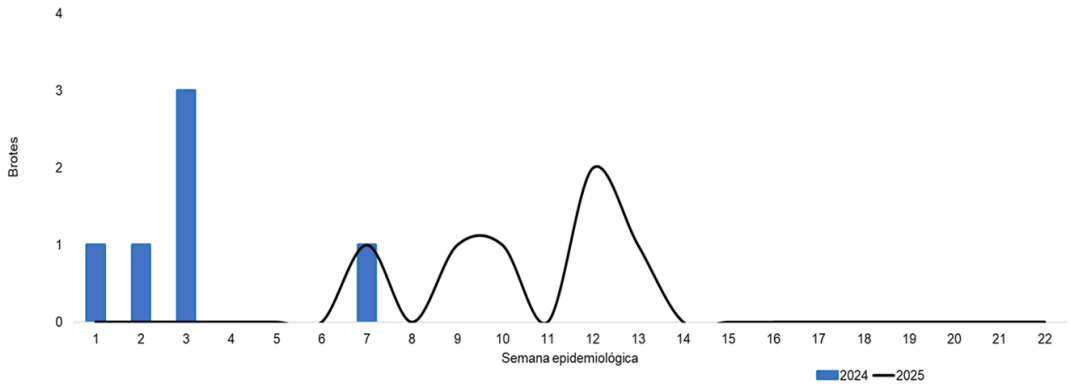


Semanas	Fallecidos
1	0
2	0
3	0
4	0
5	1
6	2
7	0
8	0
9	2
10	1
11	1
12	0
13	0
14	0
15	3
16	0
17	1
18	1
19	1
20	0
21	1
22	0
23	1

Fuente: Área de Estadística en Salud, C.C.S.S. / Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2025.

Para la semana epidemiológica 21 no se reportó ningún brote asociado a COVID-19.

Gráfico 20.
Brotes de covid-19, por semana epidemiológica en Costa Rica, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud, 2025.

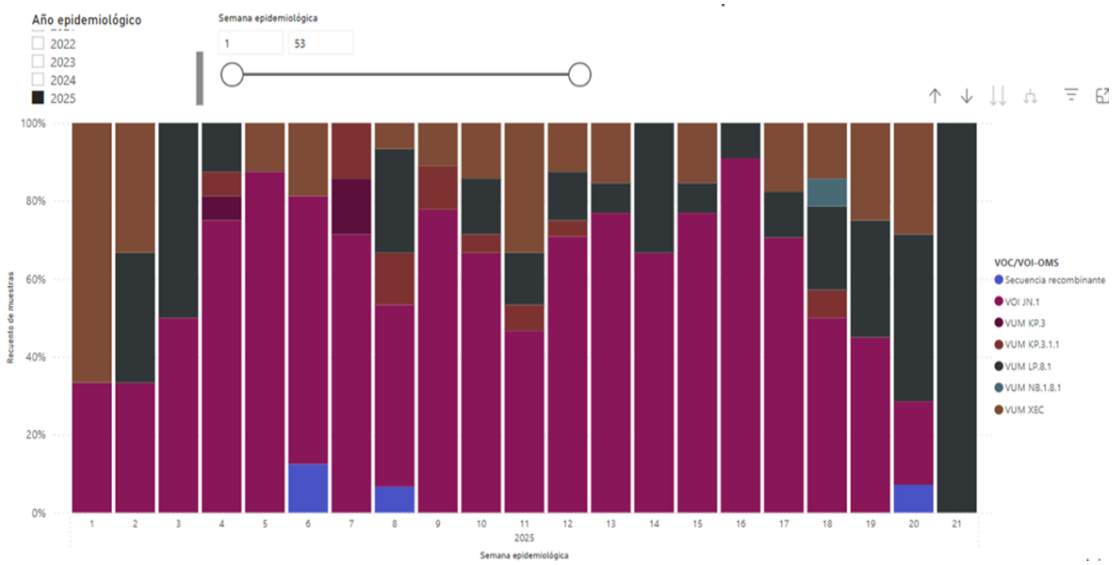
Nota: Se reportaron 24 brotes en el año 2024 y se han reportado 6 brotes en el año 2025

Variantes genómicas

Según el informe interactivo de INCIENSA revisado el 10 de junio del 2025, se reporta lo siguiente.

Gráfico 21.

Costa Rica: Proporción de linaje identificados, para Variante de Preocupación (VOC) Ómicron, Variante de Interés (VOI) y Variantes Bajo Monitoreo (VUM), por semana epidemiológica SE 1-21 del 2025.



Fuente: Sistema de Información de INCIENSA, CCSS, DATOS Facultad de Microbiología UCR, actualizado en informe interactivo en Vigilancia genómica SARS-CoV-2 al 10 de junio del 2025.

En relación con la proporción relativa de sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el periodo comprendido entre la SE-1 y la 21 del año 2025, se tiene la siguiente información.

Cuadro 1.
Costa Rica: Proporción relativa de Sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el período de las semanas epidemiológicas 1-21 del 2025

Linaje Pangolin	Cantidad	%
Secuencia recombinante	4	1.53
VOI JN.1	165	62.98
VUM KP.3	2	0.76
VUM KP.3.1.1	10	3.82
VUM LP.8.1	41	15.65
VUM NB.1.8.1	1	0.38
VUM XEC	39	14.89
Total	262	100.00

Fuente: INCIENSA, informes interactivos de variantes genómicas, corte 10 de junio 2025.

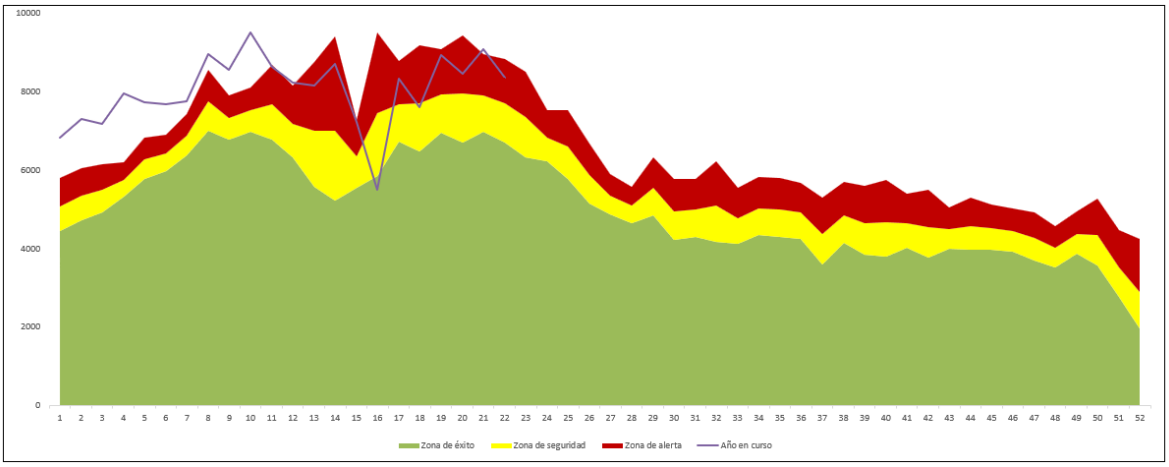
Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) al 9 de junio 2025.

Ivannia Caravaca Rodríguez.
Unidad de Epidemiología.
Dirección de Vigilancia de la Salud

En la semana epidemiológica 22 del 2025 se presentan 176835 casos acumulados de EDA. Según el comportamiento epidemiológico de este evento, se denota una curva epidémica en zona de seguridad, con una tasa de 3302 casos de diarrea por cada 100 000 habitantes.

La incidencia de las EDA para la Semana Epidemiológica (SE) 22 refleja una disminución de casos notificados en relación con el 2023, año referente por el registro del aumento de casos y tasas por 100 000 habitantes en todo el territorio nacional. Para la SE 22 se continúa observando una predisposición disminuida en la frecuencia de casos, observándose una tendencia a la baja comparado con los años anteriores, es evidente que los fenómenos climáticos del niño y la niña afectan la cantidad de casos de diarrea, este año con el fenómeno de la niña se muestra a la fecha el canal endémico en zona de alerta situación semejante en el año 2023 donde se atravesó el mismo fenómeno. Se destaca que está semana existieron discrepancias de los datos con respecto a lo notificado hasta la SE 21, lo que afectan el canal endémico y actualmente se encuentran los datos en revisión.

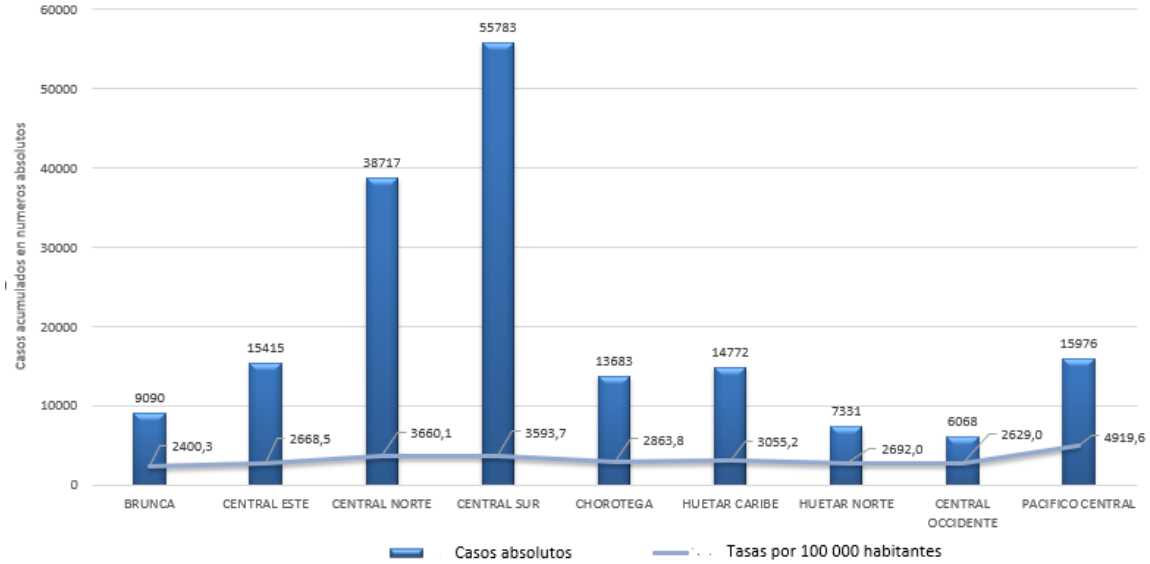
Gráfico 1
Costa Rica. Canal endémico para EDA por semana epidemiológica hasta la SE 22. Años 2017- 2025. (Se excluyen del 2020 al 2022 por pandemia COVID-19)



Fuente: Datos preliminares, Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

Los 10 cantones con mayores tasas de incidencia de EDA a la SE 21 son: Montes de Oro, Puntarenas, Orotina, Garabito, Vázquez de Coronado, Santa Cruz, Flores, San Rafael, Parrita, Goicochea, Alajuela donde predominan las tasas más altas. Las Regiones Rectoras con más casos son: Pacifico Central, Central Norte, Central Sur. El grupo de edad más afectado es el de adultos de 20 a 39 años.

Gráfico 2
Costa Rica. Incidencia de casos de EDA, según región del Ministerio de Salud. SE 22, 2025.



Fuente: Datos preliminares. Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

Se recomienda retomar las campañas de educación a la población del Protocolo de Lavado de Manos, las adecuadas prácticas de higiene personal y de cocción y manipulación de alimentos.
El sistema de salud reporta una alta frecuencia de casos de diarreas, ya sean virales o bacterianas, superiores al comportamiento usual, el Protocolo de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos dirige el proceso de la investigación adecuada de los casos, así como los flujogramas de trabajo ante diferentes posibles causas, es importante retomar las actividades de vigilancia e investigación ante las alertas.

Meningitis

Franchina Murillo Picado
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Paola Pérez Espinoza
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

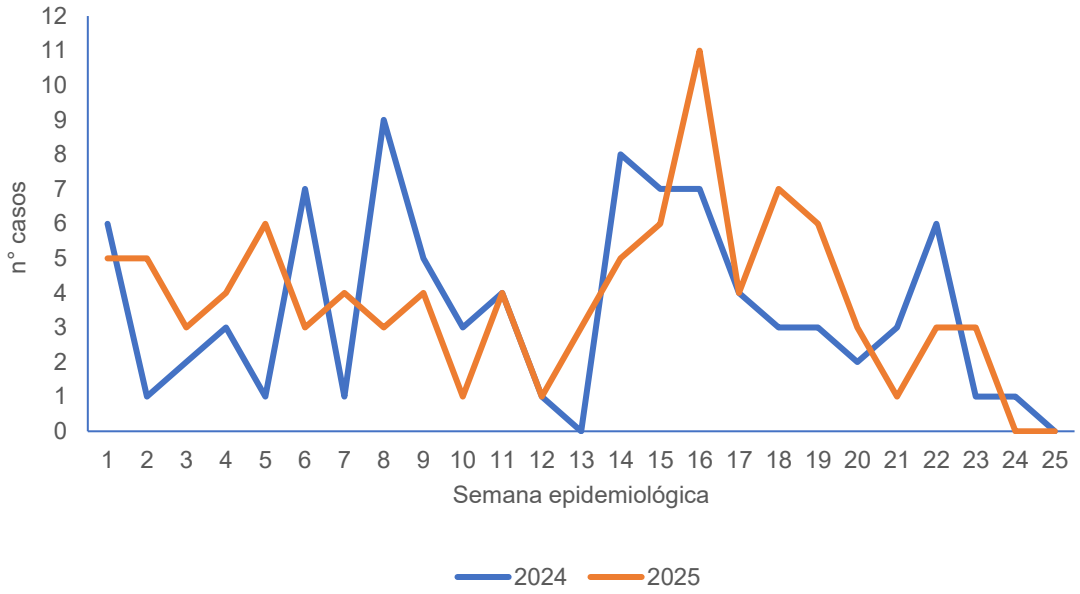
La meningitis es una peligrosa inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, causada principalmente por una infección bacteriana o vírica.

La meningitis causada por una infección bacteriana suele ser la más grave que provoca unas 250,000 muertes por año y posibles epidemias de rápida propagación. Ocasiona la muerte de una de cada diez personas infectadas, en su mayoría niños y jóvenes y deja a una de cada cinco con discapacidades duraderas, como convulsiones, pérdida de audición y visión, daños neurológicos y deterioro cognitivo.

En Costa Rica, a la semana epidemiológica 22 del año 2025, se han reportado 95 casos por boleta VE01 por sospecha de meningitis con una tasa de incidencia de 1,8 por 100,000 habitantes. En el año 2024 se reportaron 88 casos de meningitis acumulado respecto a la misma semana con un aumento de 7,9%. No se registran brotes.

De las 9 Regiones del Ministerio de Salud, la región Central Este notificó el 31,6% de los casos (30/95), seguido de la Central Sur con el 23,2% (22/95) y Central Norte con el 18,9% (18/95).

Figura 1.
Costa Rica: Casos sospechosos de meningitis comparativa año 2024 con el 2025 a la semana epidemiológica 22, 2025



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS

En la siguiente tabla se enlista los cantones con las tasas más altas de meningitis. Dota de la provincia de San José es el que tiene la tasa más alta de 12,2 seguido están Cartago con 10,1 y Osa de la provincia de Puntarenas con 9,5.

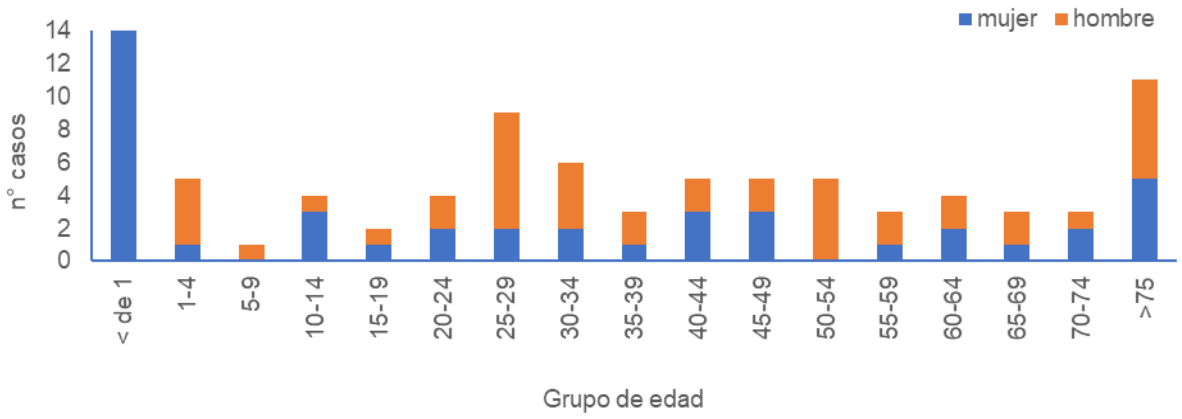
Figura 2.
Costa Rica: Casos notificados de meningitis según cantón, acumulado a la semana epidemiológica 22, 2025 (tasa p/100.000 habitantes)

cantón	casos	tasa
Dota	1	12,2
Cartago	17	10,1
Osa	3	9,5
Cañas	3	8,7
Santa Cruz	6	8,0
Leon Cortes	1	7,0
Alvarado	1	6,3
Jimenez	1	6,1
Tarrazu	1	5,2
Valverde Vega	1	4,3
Sarapiqui	4	4,2
Flores	1	3,8
La Union	4	3,4
Aserri	2	3,0
Goicoechea	4	2,8
Perez Zeledon	4	2,8
Turrialba	2	2,7
Esparza	1	2,5
Liberia	2	2,4
Santa Barbara	1	2,2
El Guarco	1	2,1
Talamanca	1	2,1
Naranjo	1	2,0
Barva	1	2,0
Santo Domingo	1	2,0
Alajuela	6	1,8
San Jose	6	1,7
San Rafael	1	1,7
Guacimo	1	1,7
Desamparados	4	1,6
Moravia	1	1,6
Montes de Oca	1	1,6
Paraiso	1	1,5
Siquirres	1	1,5
Escazu	1	1,4
Heredia	2	1,3
Pococi	2	1,2
Alajuelita	1	1,0
Grecia	1	1,0
San Carlos	1	0,5
Total	**95**	**1,8**

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS

La figura 3, indica la distribución de los casos sospechosos según sexo y grupo de edad. El 45,2% de los casos (43/95) son mujeres y el 54,7% (53/95) son hombres. El 23,1% de los casos (22/95) son menores de 1 año.

Figura 3.
Costa Rica: Casos sospechosos por meningitis según sexo y edad, a la semana epidemiológica 22, 2025



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS

Tuberculosis

Franchina Murillo Picado
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Kricia Castillo Araya
Unidad de Indicadores
Dirección de Vigilancia de la Salud

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria (*Mycobacterium tuberculosis*). Se transmite de una persona a otra a través de gotículas de aerosol suspendidas en el aire expulsadas por personas con enfermedad pulmonar activa. Esta infección puede ser asintomática en personas sanas, dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera alrededor de la bacteria. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar activa son tos, a veces con esputo que puede ser sanguinolento, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna.

En Costa Rica, según el Decreto 40556-S, la tuberculosis se ubica dentro del grupo D de enfermedades de notificación obligatoria, tiene su propio libro de registro de casos y se envía a los niveles superiores trimestralmente.

Debido a la cantidad reducida de casos que se presentan anualmente, Costa Rica se encuentra entre los 15 países de la Región con mayor oportunidad para avanzar hacia la eliminación de la TB.

A continuación, se presentan datos de estadística descriptiva, acerca de la situación epidemiológica del país en los últimos años para conocer el comportamiento del evento a nivel nacional.

Durante el período 2010–2024, la tasa de incidencia más alta de tuberculosis se registró en el año 2010, con 11,7 casos por cada 100.000 habitantes, equivalente a 533 casos notificados. En contraste, la tasa más baja se observó en el año 2020, con 6,6 por 100.000 habitantes (346 casos), coincidiendo con el contexto de la pandemia por COVID-19, lo cual pudo haber influido en una menor notificación de casos o en dificultades de acceso al sistema de salud.

El análisis de la serie temporal muestra una tendencia general decreciente entre 2010 y 2017, seguida de un rebote leve en los años 2018 y 2019. A partir de 2021, se observa una nueva alza sostenida en las tasas de incidencia, que alcanza un pico en 2023 con 9,0 por 100.000 habitantes que podría estar relacionado con la intensificación de las estrategias de búsqueda activa de casos, en el marco de la implementación del Plan de Estimación de Casos, lo cual habría favorecido una mayor detección, especialmente en grupos o poblaciones de riesgo.

En 2024 se registra una ligera disminución en la tasa de incidencia, ubicándose en 8,7 por 100.000 habitantes, con 463 casos notificados, lo que representa el segundo valor más alto desde 2015. Esto sugiere una continuidad en la actividad de vigilancia y detección activa

Para el I trimestre del 2025 se han diagnosticado 112 casos de tuberculosis con una tasa de incidencia de 2,1.

Figura N° 1.
Costa Rica: Incidencia y mortalidad por tuberculosis por cada 100.000 habitantes, 2010- I trimestre 2025

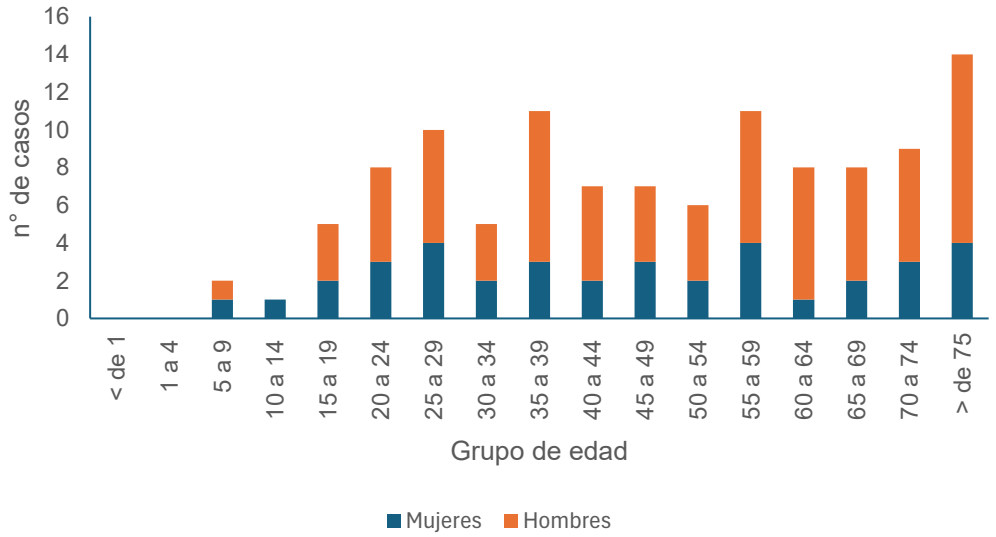
	Incidencia		Mortalidad	
Año	tasa (p/100.000 habitantes)	Casos	tasa (p/100.000 defunciones)	Casos
2010	11,7	533	0,8	41
2011	11,0	509	0,9	51
2012	10,0	469	0,9	39
2013	9,68	456	0,7	34
2014	9,9	473	0,7	42
2015	8,8	426	0,7	31

2016	7,6	370	0,7	29
2017	7,2	354	0,7	35
2018	8,2	408	0,8	38
2019	8,4	423	0,7	35
2020	6,6	346	0,6	30
2021	6,9	357	0,7	34
2022	7,7	404	0,7	34
2023	9,0	474	0,6	30
2024	8,7	463	0,7	38
2025	2,1	112	-	-

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS; Libro de registro de casos de tuberculosis

Para el I trimestre del 2025, el 33,0% (37/112) de los casos son mujeres y el 66,9% (75/112) son hombres. La media de edad es de 37,2 años y con una razón hombre/mujer es de 2,03.

Figura 2.
Costa Rica: Casos de tuberculosis según sexo y grupo de edad quinquenal, números absolutos, I trimestre 2025



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS; Libro de registro de casos de tuberculosis

El cantón de San José es el que tiene la mayor cantidad de casos (27/112) seguido de Limón (7/112) y los cantones de Alajuelita, Heredia y Liberia (6/112) respectivamente.

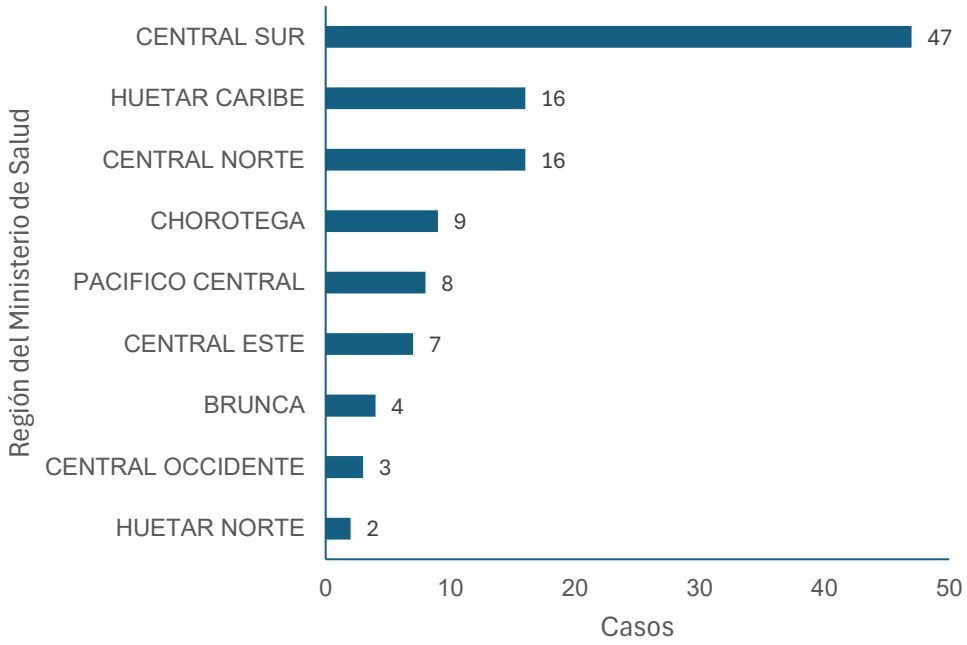
Figura 3.
Costa Rica: Incidencia de tuberculosis según cantón, I trimestre de 2025. Tasa por 100.000 habitantes

cantón	n° casos	tasa
San Jose	27	7,5
Limon	7	7,0
Alajuelita	6	6,0
Heredia	6	4,0
Liberia	6	7,2
Puntarenas	5	3,3
Desamparados	4	1,6
Cartago	4	2,4
Sarapiqui	4	4,2
Escazu	3	4,1
Santa Ana	3	4,7
Pococi	3	1,9
Tibas	2	2,3
Perez Zeledon	2	1,4
Alajuela	2	0,6
Grecia	2	2,0
Valverde Vega	2	8,6
Siquirres	2	3,0
Matina	2	4,1
Aserri	1	1,5
Acosta	1	4,4
Leon Cortes	1	7,0
Naranjo	1	2,0
San Carlos	1	0,5
Upala	1	1,7
Los Chiles	1	2,7
Paraiso	1	1,5
Oreamuno	1	1,9
Barva	1	2,0
Santa Barbara	1	2,2
Bagaces	1	3,9
Carrillo	1	2,0
Esparza	1	2,5
Osa	1	3,2
Coto Brus	1	2,3
Parrita	1	4,5
Garabito	1	3,4
Talamanca	1	2,1
Guacimo	1	1,7
Total	**112**	**2,1**

Fuente: Unidad de Indicadores de la Salud USIS, Dirección de Vigilancia de la Salud; Libro de registro de casos de tuberculosis

Durante el primer trimestre del año 2025, se notificaron casos de tuberculosis en todas las regiones del país, con una marcada concentración en la región Central Sur con el 53% de los casos (47/112), seguida por Central Norte y Huetar Caribe ambas con 16 casos.

Figura 4.
Costa Rica: Incidencia de tuberculosis según Región del Ministerio de Salud, I trimestre de 2025. Tasa por 100.000 habitantes



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS; Libro de registro de casos de tuberculosis

Infecciones de transmisión sexual

Pamela Domínguez Saavedra
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Stephany Alvarado Garita
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

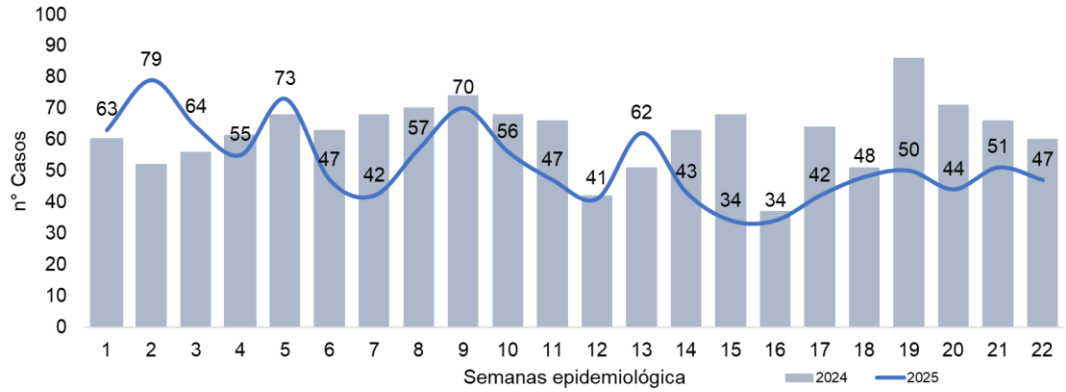
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), son de reporte obligatorio según el Reglamento de Vigilancia de la Salud 40556-S. Por consiguiente, la vigilancia es relevante para la salud pública del país. Para las primeras 22 semanas del año 2025, se han reportado las siguientes ITS: sífilis en todas sus formas, gonorrea, herpes virus y virus del papiloma humano.

Sífilis en todas sus formas

Es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria *Treponema pallidum*, la cual es totalmente prevenible y tratable. Esta infección se trasmite por relaciones sexuales sin protección y de la madre al bebé durante el embarazo. Por ende, esta infección afecta a la morbilidad y mortalidad del país.

Para las primeras 22 semanas del 2025, se han notificado 1149 casos con una tasa 21,45 por 100 000 habitantes, en el mismo periodo del año 2024 se reportaron 1365 casos, lo que representa para el año 2025 un descenso del 15,82% con 216 casos menos. En el gráfico 1, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 1.
Costa Rica: Casos confirmados por sífilis en todas sus formas, según fecha de inicio de síntomas en el reporte semanal, en los años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento de sífilis en todas sus formas en las primeras 22 semanas del año, en los hombres se reportan un 56,83% de los casos (653/1149), con una tasa de 24,25 por 100 000 habitantes, en las mujeres se reportan un 43,17% de los casos (496/1149), con una tasa de 18,63 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporto son: 20 a 64 años con 81,38% (935/1149), seguidos por el de mayores de 65 años con 10.00% con (115/1149), luego por el grupo de 15 a 19 años con 4,10% con (47/1149), y los menores de 1 año con el 4,40% de los casos (51/1149), los menores de 10 a 14 años un caso y los otros grupos no reportan casos ver cuadro 1.

Cuadro 1.
Costa Rica: Casos de sífilis en todas sus formas, por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 22 del 2025

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	51	75,5
de 1 a 4 años	0	0,0
de 5 a 9 años	0	0,0
de 10 a 14 años	1	0,3
de 15 a 19 años	47	12,4
de 20 a 24 años	142	36,5
de 25 a 29 años	183	43,0
de 30 a 34 años	174	39,2
de 35 a 39 años	123	27,2
de 40 a 44 años	101	24,8
de 45 a 49 años	79	22,8
de 50 a 54 años	48	16,3
de 55 a 59 años	37	13,3
de 60 a 64 años	48	18,3
de 65 a 69 años	38	17,8
de 70 a 74 años	32	20,5
75 años y más	45	21,3
Total	1149	21,45

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el siguiente cuadro, se presenta el comportamiento de esta enfermedad, según provincias.

Cuadro 2.
Costa Rica: Casos notificados de sífilis en todas sus formas según provincias de procedencia. Números absolutos y tasas (Tasa p/100.000 habitantes), semana 22 del 2025

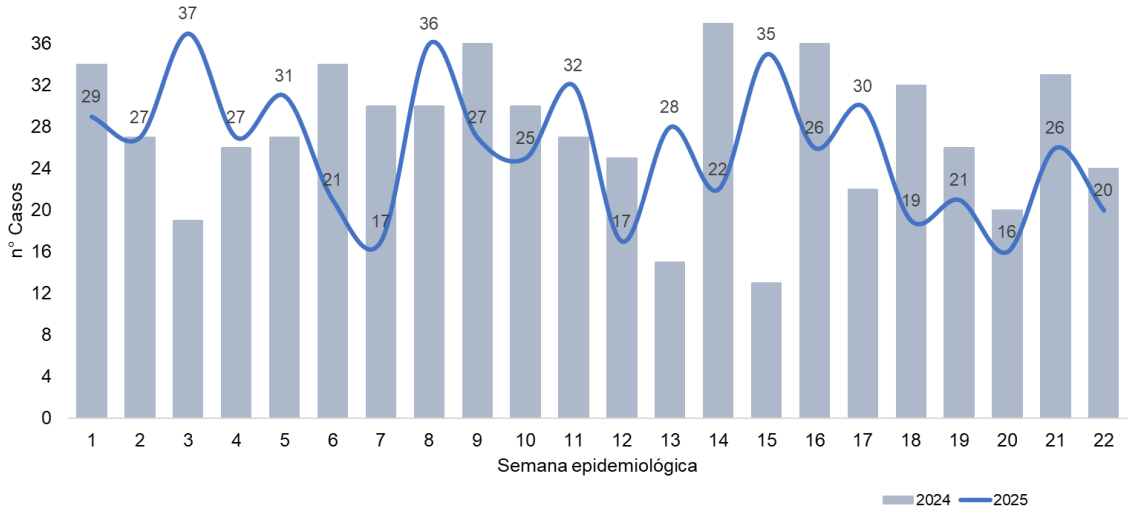
Provincias	Nº	Tasa
San José	410	23,9
Alajuela	166	15,2
Cartago	155	27,9
Heredia	84	15,0
Guanacaste	74	17,6
Puntarenas	94	17,8
Limón	166	34,3
Total	1149	21,45

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Gonorrea

Es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*, la cual es totalmente prevenible y tratable. Esta infección se trasmite por relaciones sexuales sin protección y de la madre al bebé durante el parto. Por consiguiente, esta infección afecta a la salud pública del país. En las primeras 22 semanas del 2025, se han notificado 569 casos con una tasa de 10,60 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 605 casos, lo que representa para el año 2025 un descenso del 6,00 % con 36 casos menos. En el gráfico 2, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento de esta enfermedad en las primeras 22 semanas del año en curso se ha reportado en hombres un 83,13% (473/569), con una tasa de 17,60 por 100 000 habitantes. En las mujeres se ha reportado el 16,87% (96/569), con una tasa de 3,60 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporte son: 20 a 64 años con 83,13% (473/569), seguidos por el grupo de 15 a 19 año con 13,88% (79/569), y los mayores de 65 años con 2,28% (13/569), los menores de 1 año un caso de 1 a 14 años con tres casos, ver cuadro 3.

Cuadro 3
Costa Rica: Casos de gonorrea por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 22 del 2025

Grupos de edad	Casos	Tasa
Menos 1 año	1	1,5
1 a 4	1	0,4
5 a 9	0	0,0
10 a 14	2	0,5
15 a 19	79	20,8
20 a 24	137	35,2
25 a 29	111	26,1
30 a 34	79	17,8
35 a 39	63	13,9
40 a 44	34	8,3
45 a 49	14	4,0
50 a 54	18	6,1
55 a 59	10	3,6
60 a 64	7	2,7
65 a 69	8	3,7
70 a 74	2	1,3
Más 75 años	3	1,4
Total	569	10,60

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 4, se presentan el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Cuadro 4
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según provincia. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 22 del 2025

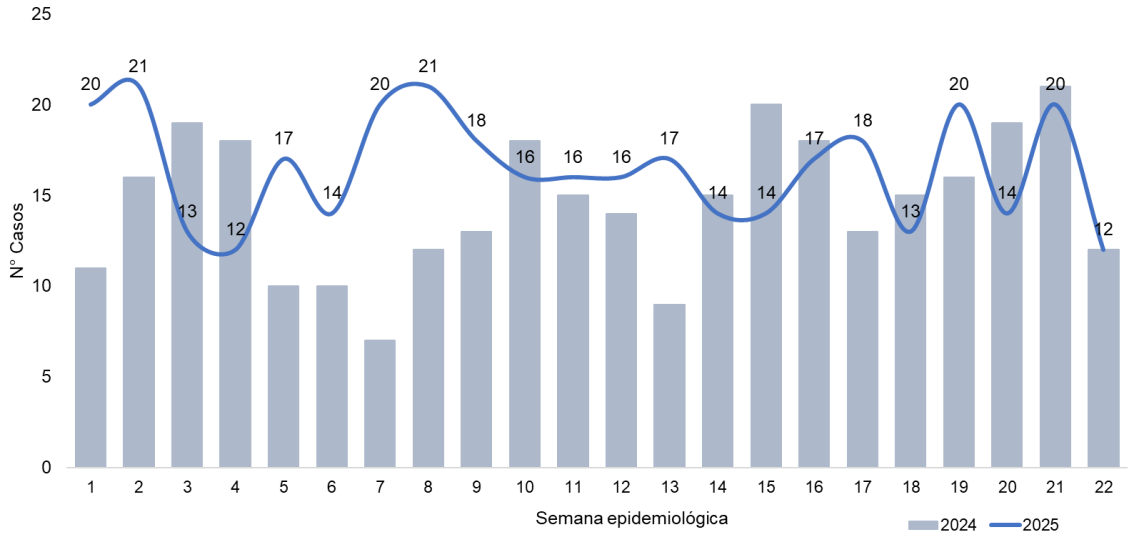
Provincias	Casos	Tasa
San José	226	13,2
Alajuela	78	7,1
Cartago	55	9,9
Heredia	56	10,0
Guanacaste	18	4,3
Puntarenas	61	11,6
Limón	75	15,5
Total	569	10,60

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Virus Herpes

El virus del herpes es otra de las Infección de transmisión sexual, que se ha reportado en las primeras 22 semanas del año en curso, con 363 casos con una tasa de 6,8 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 321 casos, lo que representa para el año 2025 un incremento del 13,00%, con 42 casos más que el periodo anterior. En el gráfico 3, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 3.
Costa Rica: Casos notificados por el virus del herpes, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento del virus del herpes en las primeras 22 semanas del año se ha notificado en mujeres un 67,49% de los casos (245/363), con una tasa de 9,2 por 100 000 habitantes, en hombres se reportó el 32,51% de los casos con (118/363), con una tasa de 4,4 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad y los que reportan más son: 20 a 64 años con 81,82% (297/363), seguidos por 15 a 19 años con 12,95% (47/363), mayores de 65 años con 4,13% con (15/363), los menores de 1 año reportan un caso y el de 10 a 14 años con tres casos 0,83%, los otros grupos no reportan casos, ver cuadro 5.

Cuadro 5.
Costa Rica: Casos de virus del herpes, por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 22 del 2025

Grupos de edad	Caso	Tasa
Menos 1 año	1	1,5
1 a 4	0	0,0
5 a 9	0	0,0
10 a 14	3	0,8
15 a 19	47	12,4
20 a 24	67	17,2
25 a 29	52	12,2
30 a 34	48	10,8
35 a 39	44	9,7
40 a 44	27	6,6
45 a 49	21	6,0
50 a 54	10	3,4
55 a 59	14	5,0
60 a 64	14	5,3
65 a 69	10	4,7
70 a 74	4	2,6
Más 75 años	1	0,5
Total	363	6,80

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 6, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Cuadro 6
Costa Rica: Casos notificados por virus del herpes, según provincias. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 22 del 2025

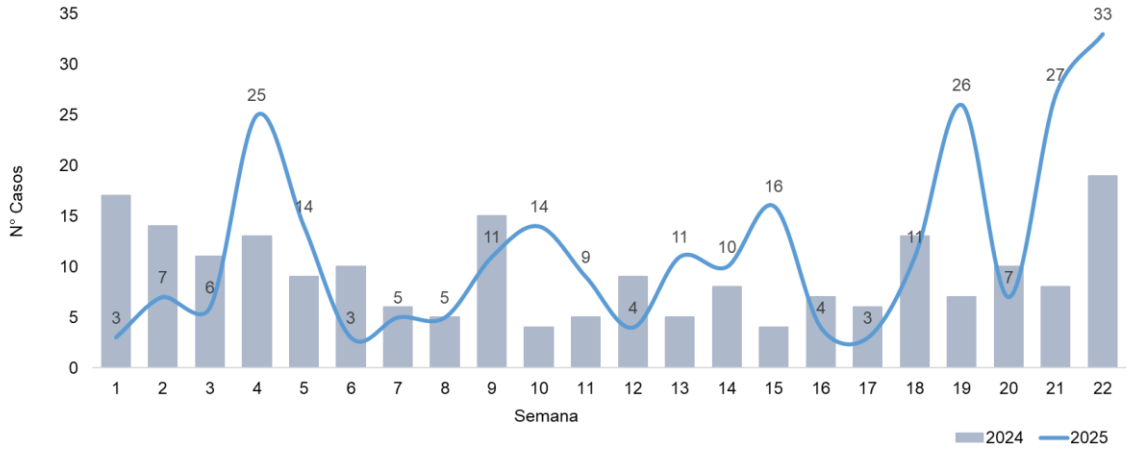
Provincias	Casos	Tasa
San José	178	10,4
Alajuela	30	2,7
Cartago	27	4,9
Heredia	27	4,8
Guanacaste	8	1,9
Puntarenas	45	8,5
Limón	48	9,9
Total	363	6,8

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Virus del Papiloma Humano (VPH)

Es una de Infección que se trasmite por por contacto de la piel o por relaciones sexuales sin protección, se puede prevenir con el uso de condones y no tener relaciones sexuales cuando la pareja tiene síntomas. En las primeras 22 semanas del 2025, se notificaron 254 casos con una tasas de 4,70 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 205 casos, lo que representa para el año 2025 un incremento del 23,9%, con 49 casos más que el periodo anterior ver gráfico 4.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados por Virus del Papiloma Humano, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento del VPH en las primeras 22 semanas del año, según sexo se notificaron en las mujeres un 92,13% (234/254), con una tasa de 8,80 por 100 000 habitantes, en los hombres se reportó el 7,87% (20/254), con una tasa de 0,70 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporte son: 20 a 64 años con 96,90% (246/254), seguidos por 15 a 19 años con 2,40% (6/254), los mayores 65 años un caso y los menores de 1 año presentan un caso y los otros grupos no reportan casos, ver cuadro 7.

Cuadro 7.
Costa Rica: Casos notificados por Virus del Papiloma Humanos, por grupos de edad. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 22 del 2025

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	1	1,5
de 1 a 4 años	0	0,0
de 5 a 9 años	0	0,0
de 10 a 14 años	0	0,0
de 15 a 19 años	6	1,6
de 20 a 24 años	16	4,1
de 25 a 29 años	15	3,5
de 30 a 34 años	46	10,4
de 35 a 39 años	48	10,6
de 40 a 44 años	36	8,8
de 45 a 49 años	26	7,5
de 50 a 54 años	17	5,8
de 55 a 59 años	24	8,6
de 60 a 64 años	18	6,9
de 65 a 69 años	1	0,5
de 70 a 74 años	0	0,0
75 años y más	0	0,0
Total	254	4,70

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 8, se presentan el comportamiento de esta enfermedad, según las siete provincias del país.

Cuadro 8.
Costa Rica: Casos notificados por Virus del Papiloma Humano, según provincia.
Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 22 del 2025

Provincias	Nº	Tasa
San José	44	2,6
Alajuela	22	2,0
Cartago	8	1,4
Heredia	7	1,3
Guanacaste	78	18,6
Puntarenas	91	17,3
Limón	4	0,8
Total	254	4,70

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Miasis por gusano barrenador en humanos

María José Lafuente González
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

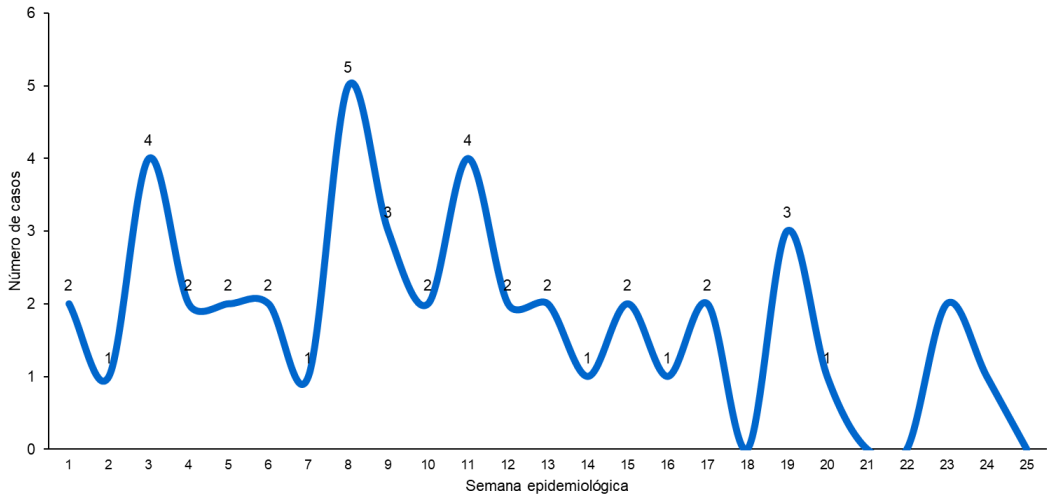
Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos de miasis por gusano barrenador en humanos para la semana epidemiológica (SE) 24 del año 2025, según establece el Reglamento de Vigilancia de la Salud Decreto N°40556-S y el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos es un evento de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de esta miasis, por medio de la boleta VE-01, para el año 2025 a la SE 24, se tienen los siguientes datos:

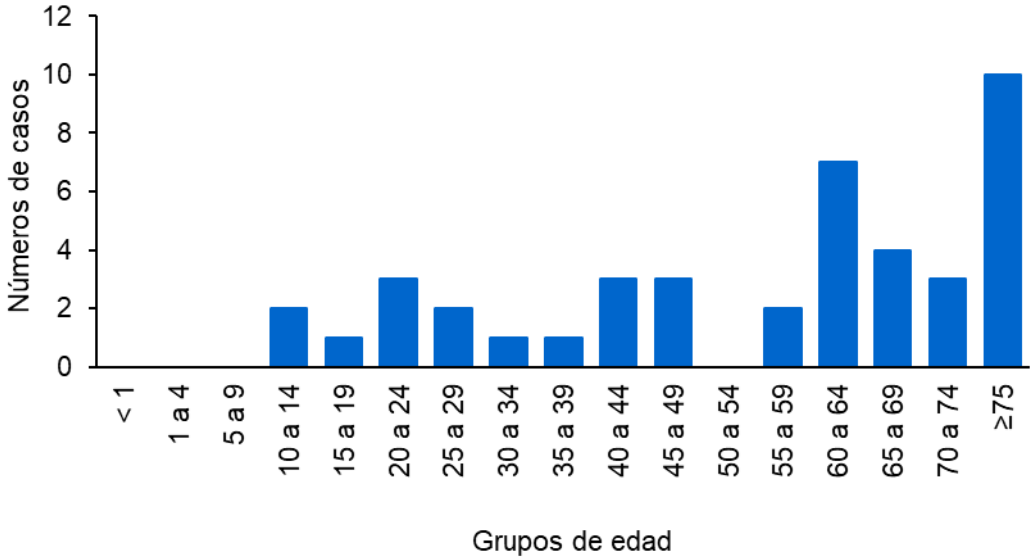
- Casos acumulados de miasis por gusano barrenado en humanos suman un total de 45 casos
- Casos por grupos de edad quinquenal tienen un predominio en las personas de 20 a 64 años (22/45) y las adultas de 65 y más años con más casos reportados (20/45).

Gráfico 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador según SE de la 01 a la 24, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador según grupos de edad quinquenal, de la SE 01 a la 24, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

El comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos, en el año 2025, presenta un predominio en los hombres con 29 casos notificados con una tasa de 1,1 por 100.000 habitantes y en las mujeres con 16 casos notificados con una tasa de 0,6 por 100.000 habitantes.

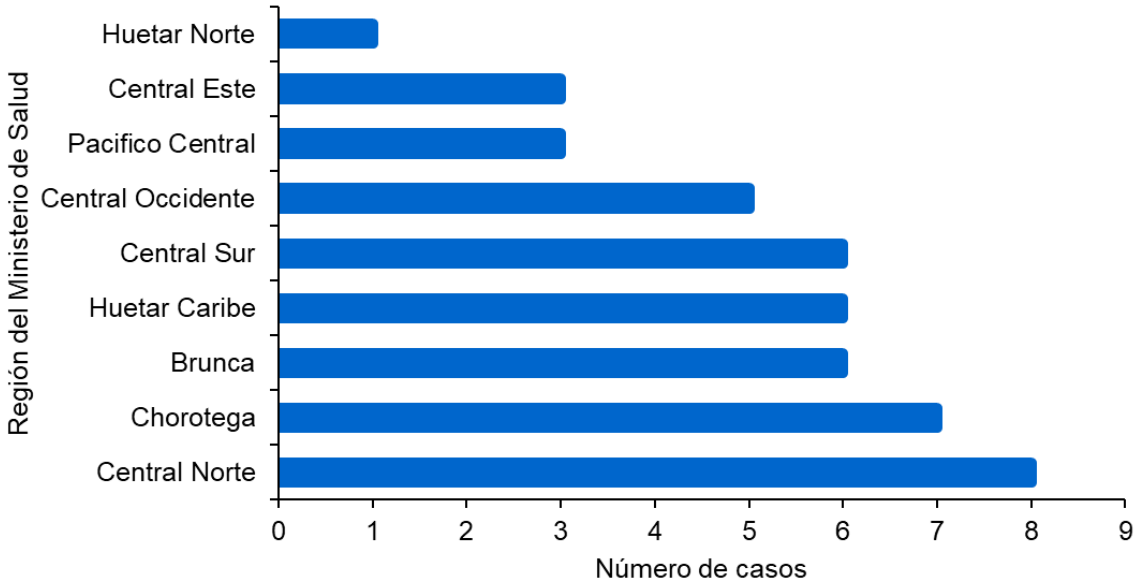
Cuadro 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasas (tasa p/100.000 habitantes) según provincia de procedencia, de la SE 01 a 24, 2025

Provincias	Casos	Tasas
Total	**45**	**0,8**
San José	7	0,4
Alajuela	11	1,0
Cartago	3	0,5
Heredia	4	0,7
Guanacaste	7	1,7
Puntarenas	7	1,3
Limón	6	1,2

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el cuadro 1, se presenta el comportamiento de esta enfermedad por provincia de procedencia, por casos y tasas por 100.000 habitantes notificados a la SE 24, presentando mayor número de casos la provincia de Alajuela (11/45) seguido por la provincia de San José (7/45), Guanacaste (7/45) y Puntarenas (7/45).

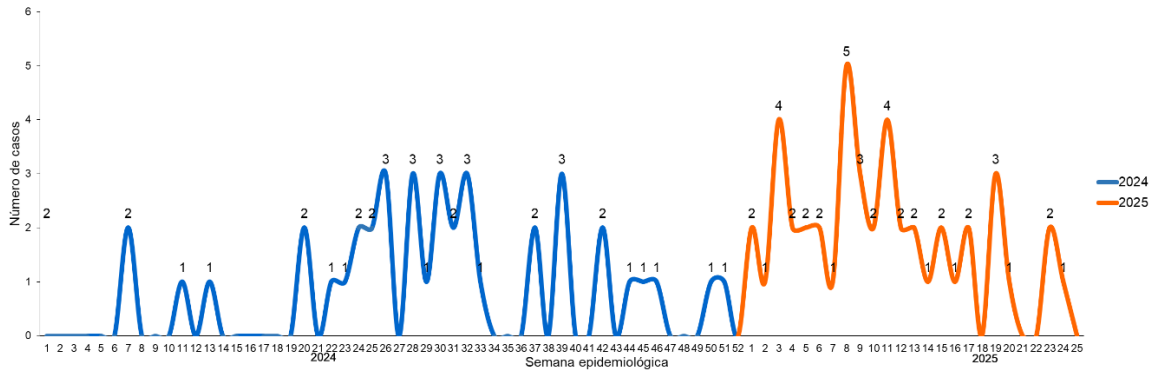
Gráfico 3
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos según región del Ministerio de Salud de procedencia, de la SE 01 a 24, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el gráfico 3, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las nueve regiones del Ministerio de Salud, siendo la región Central Norte (8/45) la que presenta el mayor número de casos.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador, según SE, año 2024 al corte de la SE 24 del 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024 y 2025

Cuadro 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador a la SE 24 del 2024 y 2025

SE	Número de casos	
	2024	2025
1	0	2
2	0	1
3	0	4
4	0	2
5	0	2
6	0	2
7	2	1
8	0	5
9	0	3
10	0	2
11	1	4
12	0	2
13	1	2
14	0	1
15	0	2
16	0	1
17	0	2
18	0	0
19	0	3
20	2	1
21	0	0
22	1	0
23	1	2
24	2	1
Total	**10**	**45**

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024 y 2025

En el gráfico 4 se puede observar el comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos por SE 01 a 52 del 2024 y SE 01 a 24 del 2025 y en el cuadro 2 el comportamiento SE 01 a 24 del 2024 y SE 01 a 24 del 2025, observando un aumento significativo de los casos durante las primeras semanas del 2025, con un total de 45 casos confirmados por esta enfermedad, siendo que para las primeras 24 semanas epidemiológicas del 2024 se confirmaron 10 casos de miasis por gusano barrenador en el país.

Dado que la mosca continúa circulando en el territorio nacional y existe la declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria Epidémica para el control y erradicación de la enfermedad de Gusano Barrenador, Decreto Ejecutivo N° 44382–MAG (*Cochliomyia hominivorax*), es de suma importancia que ante la identificación de un caso sospechoso en humanos se realice el abordaje bajo el enfoque de **Una Sola Salud**, mediante coordinación interinstitucional MS-SENASA- SINAC-CCSS según corresponda, para identificar casos sospechosos en humanos y/o animales que puedan ser atendidos de manera oportuna.

Se debe mantener la prevención y control de esta enfermedad, por lo que se brinda a continuación algunas generalidades:

- Mantener higiene personal, lavarse las manos regularmente con agua y jabón
- Control, tratamiento e higiene en lesiones en piel de acuerdo con la recomendación del médico tratante
- Asistir al establecimiento de salud público o privado cuando presente síntomas asociados a la enfermedad, tales como: dolor, malestar y picazón en el sitio de la lesión, enrojecimiento de la piel, herida con secreción, sensación que se mueve y con frecuencia, se pueden observar huevecillos y/o larvas visibles en la lesión herida
- Mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales, realizando revisiones frecuentes, así como la curación de todas las heridas e informar a las autoridades de salud animal (SENASA) sobre la aparición de animales con gusaneras para que reciban atención oportuna